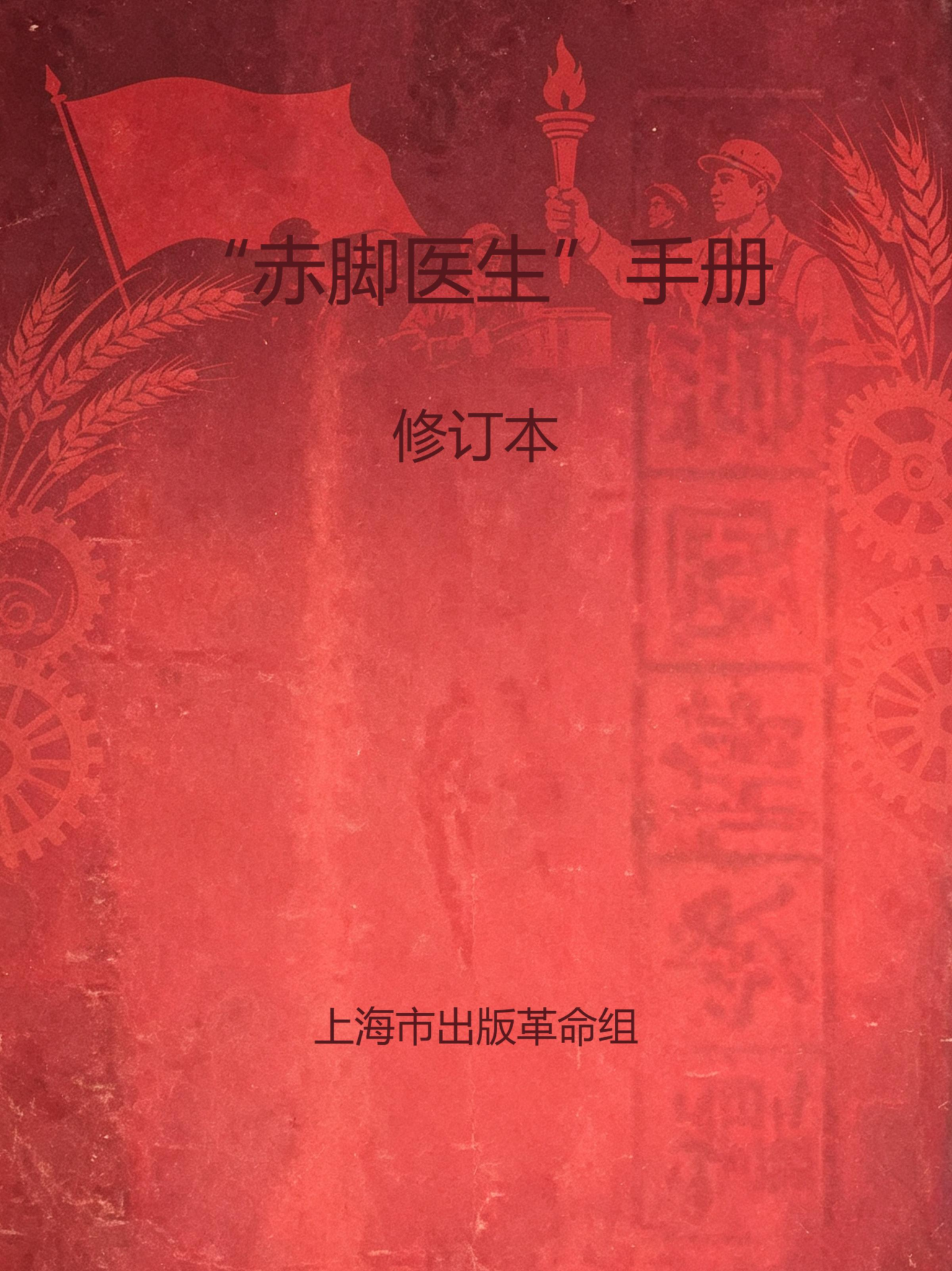




“赤脚医生”手册

修订本

上海市出版革命组

“赤脚医生”手册

上海中医学院、浙江中医学院等编

(修订本)

上海市出版革命组

“赤脚医生”手册

(修订本)

上海中医学院等编

上海市出版革命组出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海东方红印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张24 插页4 字数913,000

1970年9月第1版 1970年9月第1次印刷

书号: 14·4·45 定价: 1.80元

把 医 疗 卫 生
工 作 的 重 点 放 到
农 村 去。

刘 河 东

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务。

我们“赤脚医生”一定要无限忠于毛主席

我们是毛主席支持的“赤脚医生”，我们一定要无限忠于毛主席！

在1958年大跃进的日子里，“赤脚医生”就已经在上海郊县诞生。但是，一萌芽就被叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在上海卫生战线的代理人整垮了。为什么我们不能有贫下中农自己的“赤脚医生”？为什么广大贫下中农有病得不到及时治疗？这就是叛徒、内奸、工贼刘少奇疯狂推行反革命修正主义卫生路线的结果。我们伟大领袖毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命，彻底摧毁了以叛徒、内奸、工贼刘少奇为首的资产阶级司令部，批判了刘少奇推行的反革命修正主义卫生路线，贫下中农掌握了农村的医疗卫生大权，我们“赤脚医生”象一株茁壮的新苗，在毛主席的无产阶级卫生路线的阳光雨露下，显示着无限的生命力，成了农村卫生战线的骨干力量。

我们“赤脚医生”是在两个阶级、两条道路、两条路线的尖锐斗争中成长起来的。对于我们“赤脚医生”的诞生，广大贫下中农热情支持，积极帮助，而一小撮阶级敌人却在暗角里吹阴风——“你们做医生象哦？”

呸！住嘴！听着，“卑贱者最聪明！高贵者最愚蠢”。

我们就是贫下中农自己的医生！我们是能农能医的新型卫生人员——“赤脚医生”。

伟大领袖毛主席支持我们。毛主席指示：“把医疗卫生工作的重点放到农村去”，让我们贫下中农掌握医疗卫生大权，这是毛主席对我们贫下中农最大的关怀，最大的爱护。我们要誓死捍卫毛主席的革命路线，为毛主席争气！没有毛主席撑腰，就没有我们“赤脚医

生”。为贫下中农积极防病治病，是毛主席交给我们的光荣任务，我们坚决完成。我们一定要做好卫生防病工作，办好农村合作医疗，彻底改变农村卫生面貌。

毛主席指出：“帝国主义者如此欺负我们，这是需要认真对付的。”我们坚决照办！叛徒、内奸、工贼刘少奇鼓吹“三降一灭”，要投降帝国主义，妄图中国改变颜色，这是梦想！当前美帝国主义和社会帝国主义互相勾结，扩军备战，不断在我国边境发动武装挑衅，我们一定要严阵以待。“新的世界大战的危险依然存在，各国人民必须有所准备。”现在敌人在拿刀，我们也要拿起刀来。“提高警惕，保卫祖国”。我们“赤脚医生”一定要贯彻执行毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大方针，做好农村卫生工作。我们一切从备战出发，一定要把农村办成红彤彤的毛泽东思想大学校，帝、修、反胆敢侵犯我国，广大农村就是他们的葬身之地。

毛主席指示：“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。”医疗卫生工作要贯彻“预防为主”的方针，我们坚决照办！反革命修正主义卫生路线，要医务人员只管治病，不管防病，我们坚决反对。我们“赤脚医生”一定要把预防工作放在首位，切实做到“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”。

毛主席指示：“团结新老中西各部分医药卫生工作人员”，我们坚决照办！叛徒、内奸、工贼刘少奇推行反革命修正主义卫生路线，拜倒洋人脚下，实行民族虚无主义，妄图消灭中医，我们坚决不答应。祖国医学是个伟大的宝库，对我国人民保健事业作出了很大的贡献。我们“赤脚医生”要“学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结”，实行中西医结合，大力开展自采、自种、自制、自用中草药的群众运动。积极贯彻“古为今用，洋为中用”、“推陈出新”的方针。按照毛主席的唯物辩证法，不断清除形而上学的影响，树雄心，立壮志，敢走前人没走过的道路，敢登前人没登过的高峰，创造我国独特的新医学、新药学。

毛主席指示：“我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争。”我们坚决照办！我们开展医疗卫生工作必须按照毛主席“放手发动群众，大搞群众运动”的教导办事。反革命修正主义卫生路线，依靠资产阶级专家，在大城市的高楼大厦里指挥卫生工作，我们坚决反对。医药科学中的许多宝贵遗产本来就是劳动人民创造的。广大贫下中农有着丰富的防病治病经验。我们要虚心向贫下中农学习，并经常和贫下中农相互交流，积极开展群众性的采药、献药活动，使广大贫下中农都能掌握防病治病的方法，打一场人民战争。只有这样，才能迅速改变农村缺医少药的面貌。

我们“赤脚医生”是在毛泽东思想哺育下成长起来的。我们一定要活学活用毛主席著作，“斗私，批修”，不断提高阶级斗争、路线斗争的觉悟。为了摸清草药的脾气，更好地掌握针灸的技术，我们宁愿在自身实践探索，吃点苦头，让更多的贫下中农尝到草药和针灸治病的甜头。我们一定要以“老三篇”为座右铭，发扬“一不怕苦，二不怕死”的革命精神，“完全”、“彻底”为人民服务。我们“赤脚医生”和广大贫下中农心连心，一定要正确处理好“赤脚”和“医生”的关系，我们一定不脱离劳动，不脱离贫下中农，永远和广大贫下中农同甘共苦，永远保持劳动人民的本色，“手上有老茧，脚上有牛屎”，为贫下中农背一辈子小药箱。

“喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕烟。”广大贫下中农在毛主席的无产阶级革命路线的指引下，正满怀激情，建设社会主义新农村。在这一片大好形势下，我们“赤脚医生”怀着无限忠于毛主席的一颗红心，紧跟伟大领袖毛主席永远前进！

编 者 的 话

遵循伟大领袖毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”“认真搞好斗、批、改”的教导，我们在“医学教育革命”和“出版革命”的实践过程中编写了这本《“赤脚医生”手册》。

这本手册初稿是由上海中医学院在驻院工宣队、军宣队领导下组织了其附属单位龙华医院、曙光医院等百余名各科临床医生写成的。在编写过程中，部分编写人员先后到浙江、江西、安徽、江苏等地学习、调查，受到了广大工农兵和“赤脚医生”的热情支持和帮助。浙江中医学院的同志也参加了本书的调查、编写工作。在毛主席革命路线指引下，贫下中农掌握了农村医疗卫生大权，大搞群众运动，创立合作医疗制度，发展草医草药，这些欣欣向荣的景象，给了我们很大的教育和激励。广大“赤脚医生”对伟大领袖毛主席的赤胆忠心，深深地教育了我们。本书前面《我们“赤脚医生”一定要无限忠于毛主席》这篇文章，写的就是“赤脚医生”心里话。他们为本书提出了许多宝贵意见，提供了不少资料，在本书的编写过程中起了极其重要的作用。书中选用的民间草药、单方和疗法，就都是贫下中农、“赤脚医生”和民间草医的治疗经验。浙江省革委会及金华地区革委会卫生组，江西省革委会及九江地区革委会卫生组、德兴县革委会，东海舰队有关医院及解放军 122 医院、171 医院、109 医院、121 医院等单位以及上海郊区的一些县及公社都发扬了共产主义大协

作精神；上海市出版革命组的同志自始至终和我们一起战斗。所有这一切，对完成《“赤脚医生”手册》的编写工作起了很大作用。

这本《“赤脚医生”手册》出版了。本书的出版能不能满足“赤脚医生”的愿望，切合“赤脚医生”的需要，还有待于广大“赤脚医生”和革命医务人员的检验和批评。限于我们学习、调查和实践工作做得很不够，其中错误、缺点肯定是不少的。我们将遵循伟大领袖毛主席关于“**实践、认识、再实践、再认识**”的教导，广泛征求和听取读者的意见，不断修订再版，使本书能真正成为一本切合“赤脚医生”需要的参考用书。

一九六九年十二月

修 订 本 说 明

《“赤脚医生”手册》出版半年多来，受到了广大工农兵的普遍支持，战斗在各条战线上的工农兵群众以及广大革命医务人员纷纷来信，给予我们热情的鼓励，并提出了宝贵的意见，使我们受到了深刻的教育。在此，我们再一次向革命的读者表示崇高的敬意。

本书出版时间不长，加上我们在农村的实践经验有限，尚不能对本书作全面的修订和再版。这次，趁上海市出版革命组重印本书的机会，我们遵循伟大领袖毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”“认真作好出版工作”的教导，根据广大“赤脚医生”和有关方面的意见，并经过初步的调查研究，对本书作了部分的修订。现说明如下：

一、在解放军 85 医院、109 医院热情支持下，对“怎样认识和治疗疾病”一章作了修改，并补充了新的内容。

二、遵照毛主席“提高警惕，保卫祖国”的教导，对“战地救护与三防”一章中“三防”部分作了较多的补充和修改，以普及“三防”知识。

三、根据读者的要求，我们从实际出发，对“中医是怎样看病的”一章内容，作了较多的补充，力求避免难懂的中医术语，使初学中医的“赤脚医生”易于看懂，以便帮助理解本书各章中有关中医辨证施治的内容，同时对祖国医学的诊断知识有一个简明的概念。

四、对“常用中草药”一章作了改写，在原来的基础上，将中草药合并介绍，以便临床应用，同时增加了部分确有疗效的中草药，并与各章节中介绍的处方一致，力求前后呼应，使读者易于应用。

各章节中的草药部分，也作了适当的增删。凡临床疗效确实，植物品种明确，产地较广，毒性较小者予以增加，若临床使用不多，植物品种混淆，产地较狭，毒性较大者予以删除。

五、某些常见病、多发病的预防部分，增加了中草药的内容，以利贯彻“预防为主”的方针。由于我们的实践和搜集资料不多，所编内容尚不全面，但是，我们深信采用中草药预防疾病的前途是无限广阔的，将会得到进一步的充实和提高。

六、对某些常见病、多发病作了增加或改写，如危害人民健康较严重的血吸虫病，我们进一步征求了战斗在血防战线上的广大“赤脚医生”和革命医务人员的意见，作了反复的修改，搜集了能在农村应用的先进医疗技术。对某些少见病、地方病也有选择地作了介绍，目的在于帮助“赤脚医生”对这些病有一个概念，解决一些实际问题。我们根据自己的实践体会，并吸取了一些兄弟单位在中西医结合治疗常见病、多发病方面的新成果，趁这次修订一并列入本书。

我们以十分恳切的心情希望广大工农兵和革命医务人员以及战斗在各条战线上的革命同志能不断地对本书提出宝贵意见，批评缺点，修正错误，以便再版时能进一步提高质量。

一九七〇年十月

目 录

第一章 怎样预防疾病	1	一、八纲辨证施治	24
第一节 坚决贯彻毛主席“预 防为主”的伟大方针	1	虚实	24
第二节 防病工作必须大搞群 众运动	1	表里	24
第三节 让群众掌握防病知识	3	寒热	24
饮水卫生	3	阴阳	25
粪便管理	7	二、脏腑、气血的辨证施治	25
除害	9	心病	25
灭蚊	9	肝病	26
灭蝇	9	脾病	26
灭蟑螂	10	胃病	26
灭臭虫	10	肺病	27
灭鼠	11	肾病	27
灭钉螺	11	膀胱病	28
杀虱	12	肠病	28
化肥及农药中毒的预防	12	气证	28
第二章 怎样认识和治疗疾病	14	血证	28
第一节 怎样认识疾病	14	三、病邪的辨证施治	29
进行调查研究,掌握感性知识	14	风证	29
综合感觉材料,作出初步诊断	16	湿证	29
第二节 怎样治疗疾病	16	痰证	30
突出无产阶级政治,坚持四个		暑证	30
第一	17	燥证	30
树立整体观念,反对孤立片面	18	食积	30
深入事物本质,治病必须治本	18	虫证	30
抓住主要矛盾,注意主次缓急	19	四、热性病的辨证施治	31
区别不同情况,因时因地制宜	19	第四章 针灸与推拿	32
坚持土洋并举,贯彻中西结合	20	第一节 针灸	32
第三章 中医是怎样看病的	21	针刺的方法	32
第一节 四诊要点	21	艾灸的方法	34
问诊	21	常用穴位	36
望诊	21	常见病症的针灸配穴	46
闻诊	22	穴位的经络联系	51
切诊	22	第二节 耳针疗法	55
第二节 辨证施治	23	第三节 推拿疗法	61
		第五章 新医疗法	69
		第一节 新针疗法	69

新针疗法特点	69
新穴介绍	70
新针疗法要穴治疗歌	72
第二节 卤碱疗法	73
第三节 新罐疗法	74
第四节 穴位埋线疗法	75
第五节 穴位注射疗法	76
第六节 割治和挑治疗法	78
第六章 常用中草药	80
第一节 草药防治疾病的好处	80
第二节 中草药一般知识	81
第三节 常用中草药简介	85
一、解表药	85
紫苏、木笔(辛夷花)、胡荽(芫荽草)、杜衡、黄皮、紫葳、黄荆、麻黄、桂枝、荆芥、防风、葱白、细辛、柴胡、桑叶、白菊、黄菊、葛根、薄荷、蝉蜕	
二、清热药	90
蒲公英、紫花地丁、鱼腥草、马齿苋、莓草、鸭跖草、筋骨草、木芙蓉(芙蓉花)、忍冬(金银花)、菊花脑(野菊)、猪殃殃、龙葵、七叶一枝花、地胆草、马兰、白英、一枝黄花、婆婆针(鬼针草)、半边莲、爵床(小青草)、地耳草、榄核莲(一见喜)、白花蛇舌草、天胡荽、凤尾草、一点红、虎耳草、垂盆草、抱石莲、天葵、蛇莓、羊蹄、乌蕪莓、漆姑草、夏枯草、梔子(生山梔)、牛膝(土牛膝)、金鸡脚、三白草、野芥麦(开金锁)、积雪草(落得打)、翻白草、白毛垂花蓼(辣蓼)、滴水珠、三叶青、长萼鸡眼草(鸡眼草)、水蜈蚣、酸浆(挂金灯)、拳参、黄独(黄药子)、獾猴桃(藤梨根)、苦参、蒲葵(葵树子)、了哥王、	

古山龙、三丫苦、石膏、知母、芦根、竹叶、决明子、青箱子、鲜地黄、玄参、丹皮、紫草、地骨皮、连翘、大青叶、板蓝根、白鲜皮、白头翁、黄芩、黄连、黄柏、龙胆草、茵陈、苦参、败酱草

三、祛风湿药122

苍耳、海州常山(臭梧桐)、薏苡、细柱五加、大血藤(红藤)、豨薟、木防己、骨碎补、络石、两面针、独活、羌活、木瓜、威灵仙、秦艽、蚕砂、苍朮、松节、桑枝、寻骨风、乌梢蛇、白花蛇(蕘蛇)、蜂房

四、利尿渗湿药128

连钱草(金钱草)、车前、黄毛耳草、酢浆草、海金沙、马蹄金、黄花菜(萱草根)、过路黄(对坐草)、蒨蓄、杠板归(河白草)、合萌(田皂角)、苧麻、土茯苓、阴行草(铃茵陈)、薏苡(米仁根)、摩来卷柏(岩柏)、铃兰、茯苓、猪苓、泽泻、木通、滑石、草薢、赤小豆、地肤子、玉米须、冬瓜皮、冬瓜子

五、化痰止咳药139

半夏、薤白、萝藦(天浆壳)、鼠麴草(佛耳草)、旋复花、胡颓子、蔓生百部(百部)、石胡荽(鸫儿不食草)、杏仁、紫菀、款冬花、桔梗、前胡、白果、贝母、瓜蒌、桑白皮、枇杷叶、天南星、白芥子、竹茹

六、理气药144

莎草(香附)、枸橼(枸橼梨)、马兜铃(青木香)、野蔷薇(白残花)、楝(苦楝子)、野葱(薤白头)、木香、橘皮、青皮、枳

- 壳、厚朴、延胡索、郁金、乌药、香橼皮、柿蒂
- 七、活血药149
- 六月霜(刘寄奴)、紫金牛(平地木)、地瓜儿苗(泽兰)、益母草、虎杖、马鞭草、茅莓(天青地白草)、紫葳(凌霄花)、算盘子、陆英(蒴藋)、六月雪、瓜子金、蚊母草、珍珠菜、盘柱南五味子(红木香、紫金皮)、紫参(石见穿)、丹参、水晶花(银线草)、川芎、赤芍、桃仁、红花、五灵脂、三棱、莪朮、王不留行、月季花、姜黄、牛膝(怀牛膝、川牛膝)
- 八、止血药160
- 大蓟、白茅(白茅根)、龙芽草(仙鹤草)、小蓟、茜草、侧柏、鱧肠(墨旱莲)、铁苋菜、地锦草、水苦葵、地榆、槿木、瓦韦(七星草)、紫珠、鹿蹄草(鹿衔草)、卷柏、槐花(生槐米、槐米炭)、陈棕(陈棕炭)、藕节、白及、三七(参三七、田三七)、血余、菊三七、艾、蚕豆花(蚕豆梗)、丝瓜叶、灶心土、荠菜花、蒲黄、万年青根(白河车)
- 九、消食药170
- 麦芽、谷芽、神曲(焦六曲、六神曲)、鸡内金(鸡内金)、山楂、莱菔子
- 十、驱虫药171
- 木槿(川槿皮)、贯众、毛茛、羊蹄躅、除虫菊、使君子、槟榔、石榴根皮、大蒜、鸦胆子、苦楝根皮
- 十一、泻下药174
- 乌柏、大黄、芒硝、郁李仁、大戟、甘遂、商陆、牵牛子(黑丑、白丑)、葶苈子
- 十二、清暑药175
- 黄花蒿(秋蒿)、藿香、佩兰、香薷、荷叶
- 十三、祛寒药176
- 竹叶椒(土花椒)、附子、肉桂、干姜、吴茱萸
- 十四、安神、镇痉药177
- 景天三七、合欢(合欢皮)、钩藤、远志、酸枣仁、柏子仁、珍珠母、牛黄、菖蒲、磁石、龙齿、蚯蚓、全蝎、蜈蚣
- 十五、补益药180
- 山药、锦鸡儿(金雀根)、枸杞、何首乌、蛇床、构树(楮实子)、女贞、羊乳(山海螺)、麦冬、枸杞(功劳叶)、野大豆(野毛豆)、阔叶十大功劳、美丽崖豆藤(牛大力)、党参、黄芪、白朮、大枣、甘草、孩儿参、黄精、白芍、当归、桑椹、地黄(大生地、熟地)、鹿角(鹿角片、鹿角粉)、肉苁蓉、人胞(紫河车)、杜仲、狗脊、续断(川断)、补骨脂、淫羊藿(仙灵脾)、益智仁、菟丝子、韭菜子、沙参、龟板、天冬、石斛(川石斛、金石斛、鲜金石斛)、百合
- 十六、收敛药190
- 碎米荠、金樱子、臭椿(椿根皮)、桃金娘(岗稔根、岗稔果、岗稔叶)、盐肤木、山茱萸、五味子、牡蛎、覆盆子、芡实、诃黎勒(诃子、诃子肉)、乌梅、麻黄根、糯稻根、鸡冠花、桑螵蛸、乌贼骨(海螵蛸)、莲须
- 十七、软坚药194
- 海藻、昆布、海带、鳖甲
- 十八、外用药194
- 硫黄、轻粉、雄黄(腰黄)、硼

砂(月石)、炉甘石、铅丹(广丹、东丹、黄丹、红丹、桃丹粉)	
第七章 战地救护与三防	196
第一节 火线抢救的一般原则	196
第二节 火线抢救的一般方法	197
第三节 战地救护四项技术	198
止血	198
包扎	200
固定	208
搬运	209
第四节 原子武器的防护	213
第五节 化学武器的防护	218
第六节 细菌武器的防护	221
第八章 常见症状的诊断与处理	223
咳嗽	223
胸痛	226
呕吐	228
腹泻	230
黄疸	234
肝脾肿大	237
腹水	239
便血	242
血尿	244
水肿	246
头痛	248
眩晕	252
第九章 急症处理	255
高热	255
腹痛	258
昏迷	262
小儿惊厥	265
休克	267
晕厥	270
中暑	271
呼吸困难	272
气胸	275

血胸	276
出血	276
咯血	276
呕血与黑粪	278
鼻出血(鼻衄)	280
常用农药及除害药物中毒	280
有机磷杀虫剂中毒	280
土农药雷公藤中毒	281
常用除害药物中毒	282
急性中毒	282
喉阻塞	287
异物	287
疯狗咬伤	289
毒蛇咬伤	289
电击伤	291
溺水	293
第十章 传染病	295
第一节 概说	295
传染病的传播	295
控制和消灭传染病	296
第二节 常见传染病	303
流行性感胃	303
流行性乙型脑炎	304
流行性脑脊髓膜炎	307
传染性肝炎	309
细菌性痢疾	310
伤寒及副伤寒	313
斑疹伤寒	314
结核病	315
肺结核	315
肾结核	316
肠结核	316
结核性胸膜炎	317
稻热病(钩端螺旋体病)	317
败血症	318
第三节 其他传染病	321
第十一章 寄生虫病	323
血吸虫病	324
急性血吸虫病	326
慢性血吸虫病	326
晚期血吸虫病	333

蛔虫病	342	慢性肺原性心脏病(肺心)	388
钩虫病	344	心律失常	389
蛲虫病	346	心力衰竭	391
绦虫病	347	循环系统其他疾病	393
丝虫病	347	第四节 泌尿系统	394
疟疾	350	解剖生理知识	394
阿米巴痢疾	352	体格检查方法	395
姜片虫病	353	肾小球肾炎	395
中华支睾吸虫病(中华肝吸虫 病)	354	急性肾炎	395
肺吸虫病	354	慢性肾炎	397
第十二章 内科疾病	356	急慢性尿路感染	399
第一节 呼吸系统	356	泌尿系结石	400
解剖生理知识	356	泌尿系统其他疾病	401
体格检查方法	357	第五节 血液系统	402
上呼吸道感染	359	贫血	403
急性支气管炎	361	缺铁性贫血	403
慢性支气管炎	361	再生障碍性贫血	404
哮喘	362	紫癜	405
支气管扩张	364	血小板减少性紫癜	405
大叶性肺炎	365	过敏性紫癜	406
病毒性肺炎	366	白血病	406
呼吸系统其他疾病	367	急性白血病	407
第二节 消化系统	368	慢性白血病	408
解剖生理知识	368	血液系统其他疾病	408
体格检查方法	370	第六节 神经系统	409
急性胃肠炎	371	解剖生理知识	409
慢性胃炎	373	体格检查方法	410
溃疡病	374	三叉神经痛	411
慢性肠炎	375	坐骨神经痛	412
胃肠神经官能症	376	面神经瘫痪	414
肝硬化	377	癫痫	414
消化系统其他疾病	379	脑血管意外	416
第三节 循环系统	379	偏头痛	417
解剖生理知识	379	神经系统其他疾病	418
体格检查方法	382	第七节 内分泌系统	419
风湿病	383	糖尿病	419
慢性风湿性瓣膜病(风心)	385	单纯性甲状腺肿	420
高血压病与高血压性心脏病 (高心)	385	甲状腺机能亢进	421
冠状动脉硬化性心脏病(冠心)	387	内分泌系统其他疾病	423
		第八节 其他	424
		神经衰弱	424

癔病(歇斯底里)	425	第二节 妇女病	456
精神分裂症	426	月经不调	456
暑湿病	428	闭经	458
类风湿性关节炎	428	痛经	459
第十三章 小儿常见病	431	带下	460
第一节 概说	431	盆腔炎	462
小儿的生长发育	431	急性盆腔炎	462
小儿保育	431	慢性盆腔炎	462
小儿诊断的特点	432	子宫脱垂	463
小儿治疗的特点	433	女生殖器肿瘤	464
第二节 新生儿疾病	434	子宫肌瘤	464
新生儿颅内出血	434	卵巢囊肿	465
新生儿脐炎	434	宫颈癌	466
新生儿败血症	435	第三节 接生知识	466
新生儿破伤风	435	产前检查	466
新生儿硬皮症	436	流产	470
第三节 小儿传染病	436	妊娠中毒病	473
麻疹	436	早期妊娠中毒病(妊娠剧吐)	473
水痘	438	晚期妊娠中毒病	473
猩红热	439	产前出血	474
流行性腮腺炎	439	前置胎盘	474
百日咳	440	胎盘早期剥离	475
白喉	441	正常分娩(顺产)	475
脊髓灰质炎	443	异常分娩(难产)	478
第四节 小儿各系统疾病	444	胎头方位异常	479
支气管肺炎	444	臀位	479
口腔炎	445	横位	481
鹅口疮	445	内外倒转术	482
疱疹性口腔炎	446	双胎	484
溃疡性口腔炎	446	子宫收缩乏力	484
婴儿腹泻	447	脐带脱垂	485
佝偻病	449	子宫破裂	485
婴儿手足搐搦症	451	产后出血	486
低血糖症	451	产褥感染	486
遗尿	451	产后恶露不绝	487
暑热症	452	新生儿处理	488
第十四章 妇女病和接生常识	453	第十五章 计划生育	490
第一节 概说	453	提倡晚婚	490
女性生殖器解剖	453	避孕	491
女性生殖器生理	454	人工流产	494
阴道检查	455	绝育	496

第十六章 外科疾病	499
第一节 外科感染	499
概说	499
疖	502
痈	502
丹毒	503
蜂窝组织炎	503
急性淋巴管炎	504
急性淋巴结炎	505
乳腺炎	505
手指的化脓性感染	506
甲沟炎	507
脓性指头炎	507
化脓性腱鞘炎	507
下肢溃疡	509
下肢静脉曲张	509
化脓性骨髓炎	509
化脓性关节炎	510
全身化脓性感染	511
淋巴结结核	512
骨与关节结核	513
第二节 急腹症	514
急性阑尾炎	514
急性腹膜炎	516
胆道蛔虫病	518
急性胆囊炎、胆石症	519
胃、十二指肠溃疡急性穿孔	520
肠梗阻	521
急性胰腺炎	523
第三节 肛门病	524
内痔	525
外痔	527
血栓性外痔	527
结缔组织性外痔	528
混合痔(内外痔)	528
息肉痔(直肠息肉)	529
肛裂	529
肛门直肠周围脓肿	530
肛瘘	530
肛门直肠脱垂	531
第四节 肿瘤	532

临床分类	532
临床常见的肿瘤	532
良性肿瘤	532
恶性肿瘤	533
第五节 其他	537
烧伤	537
疝	541
睾丸鞘膜积液	545
破伤风	547
第十七章 伤科	549
第一节 骨骼系统解剖生理	
概说	549
第二节 骨折	553
锁骨骨折	558
肱骨外科颈骨折	559
肱骨干骨折	561
肱骨髁上骨折	563
前臂双骨折	564
桡骨下端骨折	566
股骨颈骨折	566
股骨粗隆间骨折	567
股骨干骨折	568
髌骨骨折	569
胫腓骨骨折	570
踝部骨折	571
指(趾)骨骨折	573
胸腰椎压缩性骨折	573
第三节 脱位	577
下颌关节脱位	577
肩关节脱位	578
肘关节脱位	579
小儿桡骨头半脱位	580
牵拉肩	580
髋关节脱位	580
髌骨脱位	581
第四节 软组织损伤	581
颈部扭伤	582
肩关节周围炎	583
肱骨外上髁炎	584
腕部与手指的狭窄性腱鞘炎	584
腱鞘囊肿	585

膝部扭挫伤	585	鼻前庭炎、鼻前庭疖	618
踝部扭伤	586	鼻粘膜慢性炎症(慢性鼻炎)	619
胸部迸挫伤	587	副鼻窦炎	620
附:肋骨骨折	588	急性副鼻窦炎	620
第五节 颅脑损伤	589	慢性副鼻窦炎	620
第六节 腰部急性挫伤和慢性劳损	592	鼻息肉	621
第十八章 眼病	598	第四节 咽喉病	621
第一节 眼的简单结构	598	急性扁桃体炎	621
眼球	598	慢性咽炎	623
眼的附属器	598	喉炎	623
第二节 眼的一般检查方法	599	第五节 口腔病	624
第三节 常见眼病	600	牙痛	624
麦粒肿	600	简易拔牙	626
霰粒肿	601	第二十章 皮肤病	627
睑缘炎	601	第一节 概说	627
倒睫与眼睑内翻	602	临床表现	627
泪囊炎	603	外用药的剂型及常用药物介绍	627
流泪症	604	中医辨证施治	627
沙眼	604	局部治疗原则	629
结膜炎	605	脱(过)敏疗法	630
翼状胬肉	606	第二节 常见皮肤病	630
角膜炎	607	农业皮肤病	630
巩膜炎	608	湿疹	632
虹膜睫状体炎	609	荨麻疹	633
青光眼	610	瘙痒病	634
白内障	611	神经性皮炎	635
眼外伤	611	接触性皮炎	636
附:几种眼药水配制法	612	药物性皮炎	637
第十九章 耳鼻咽喉病及口腔		癣	638
病	613	脓疱疮	640
第一节 耳鼻咽喉的简单结构	613	单纯疱疹	641
第二节 耳病	614	带状疱疹	641
外耳道疖、外耳道炎	614	扁平疣	642
耵聍阻塞	614	寻常疣	642
化脓性中耳炎	615	痒疹	642
耳源性眩晕(美尼尔氏病)	616	银屑病	643
聋哑	617	结节性红斑	644
第三节 鼻病	618	冻疮	645
		皲裂	645
		第三节 其他皮肤病的简易治疗	646

第二十一章 附篇	649	抗高血压药	701
第一节 常用诊疗技术	649	升血压药	702
人工呼吸和心脏按摩	649	补血药	703
体温、脉搏、呼吸和血压测量方		止血药	704
法	651	抗凝血药	705
冷敷法与热敷法	652	补充血容量药	706
眼部用药和冲洗法	653	利尿药与脱水剂	707
鼻滴药法	654	抗过敏药	708
耳滴药法	654	驱肠道寄生虫药	710
消毒与灭菌	654	抗血吸虫及丝虫药	711
注射技术	655	抗疟药	712
输液和输血	657	抗阿米巴药	714
输血前的血型鉴定和交叉配合		磺胺及呋喃类药物	715
试验	660	抗菌素	717
静脉切开术	661	抗结核病药	721
常用穿刺技术	663	抗肿瘤药	722
洗胃法	664	维生素	724
灌肠法	665	激素	727
导尿法	666	纠正电解质酸碱平衡用药	732
常用药物过敏试验	667	解毒药	733
伤口处理	668	子宫收缩药	734
麻醉法	671	避孕药	736
第二节 常用中成药	673	眼科用药	737
第三节 常用西药	679	耳鼻喉科用药	738
中枢兴奋药	679	外科用药	738
催眠药、抗惊厥药	680	附一：常用静脉滴注药物配伍	
镇静药、安定药	682	禁忌表	740
解热镇痛药、抗风湿药	684	二十五种常用静脉滴注药物	
镇痛药	687	配伍禁忌表	740
抗癫痫药	688	十八种静脉滴注药物的配伍	
兴奋横纹肌与平滑肌药	689	实验结果	741
祛痰镇咳药	689	附二：常用临床化验正常值	742
止喘药	691	血液	742
消化健胃药	692	血液化学	742
制酸药	693	肝脏功能试验	743
解除平滑肌痉挛药	695	肾脏功能试验	744
泻药	696	尿液	744
止泻药	697	脑脊液	744
强心与纠正心律失常药	698		

第一章 怎样预防疾病

高举毛泽东思想伟大红旗，坚持在卫生防病工作中用毛泽东思想挂

帅，是我们“赤脚医生”防病工作中最根本的任务。

第一节 坚决贯彻毛主席“预防为主”的伟大方针

预防为主还是重治轻防，是卫生战线两个阶级、两条道路、两条路线斗争的重要体现。我们的伟大领袖毛主席十分关心广大人民群众的健康，在1945年就指出：“……所谓国民卫生，离开了三亿六千万农民，岂非大半成了空话？”“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。”1952年又教导我们：“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”。1958年，毛主席亲自视察了杭州小营巷爱国卫生工作。1958年7月1日，毛主席又写了光辉诗篇《送瘟神》二首，给全国人民以极大鼓舞。1965年，毛主席又对卫生工作作了划时代的极为重要的指示：“把医疗卫生工作的重点放到农村去。”这一系列伟大指示给医疗卫生工作指出了根本的方向。预防为主，大搞爱国卫生运动，对于增强人民体质，提高健康水平，抓革命，促生产，促工作，促战备，巩固无产阶级专政，具有重要意义。做好卫生

防病工作是“赤脚医生”最主要的任务。叛徒、内奸、工贼刘少奇长期以来推行反革命修正主义卫生路线，重治轻防，重城市轻农村，疯狂鼓吹“技术第一”、“名利挂帅”、“锦标主义”、“形式主义”，使卫生工作冷冷清清，把卫生部篡改为“城市老爷卫生部”，对抗毛主席的革命卫生路线，破坏广大劳动人民的卫生防病工作，犯下了滔天罪行。

我们“赤脚医生”无限忠于毛主席，誓死捍卫毛主席的无产阶级卫生路线。我们坚决贯彻毛主席“预防为主”的伟大方针，用毛泽东思想统帅卫生预防工作，彻底肃清刘少奇反革命修正主义卫生路线的流毒，批判“重治轻防”的错误思想，在党的领导下，发动并依靠广大革命群众，轰轰烈烈、踏踏实实地深入持久地开展爱国卫生运动，做好防病工作，为提高我国人民的健康水平而努力奋斗。

第二节 防病工作必须大搞群众运动

伟大领袖毛主席教导我们说：“人民群众有无限的创造力。”卫生防病工

作必须依靠广大贫下中农“自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯

作斗争”。在毛主席革命路线指引下，工农兵群众在卫生防病工作中积累了丰富经验。根据已积累的丰富经验，主要可归纳为一宣传、二依靠、三狠抓。

一、宣传 卫生防病宣传工作最根本的任务是宣传毛泽东思想，宣传毛主席对卫生工作一系列的指示及其伟大意义。我们要“善于把党的政策变为群众的行动，善于使我们的每一个运动，每一个斗争，不但领导干部懂得，而且广大的群众都能懂得，都能掌握”。我们要宣传除四害，讲卫生，预防疾病，增强人民体质是毛主席的号召，是社会主义革命和社会主义建设的需要，是加强战备的需要。我们要宣传爱国卫生运动和生产的关系。广大贫下中农不仅要“抓革命，促生产”的闯将，也要做除害灭病的模范。

卫生宣传工作必须狠抓革命的大批判，彻底批判叛徒、内奸、工贼刘少奇推行的反革命修正主义卫生路线。

卫生宣传教育要结合季节、生产持久反复地进行。要采取通俗易懂和群众喜闻乐见的多样化形式，除了口头宣传、写卫生标语外，还可用黑板报、宣传画、展览会、广播站、上卫生课以及卫生文娱宣传、表扬好人好事等形式。

二、依靠 就是依靠群众，依靠党的领导。伟大领袖毛主席教导我们：“我们历来主张革命要依靠人民群众，大家动手，反对只依靠少数人发号施令。”卫生工作是群众性的工作，必须实现领导与群众相结合；专业队伍与群众运动相结合；突击和经常相结合。为了加强党对卫生工作的领导，必须健全各级卫生组织，在党的统一领导

下成立爱国卫生工作委员会或领导小组。它的任务是：发动群众，开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动，并做好同级革委会参谋工作，在革委会制定农业生产规划的同时，制订卫生工作计划；在安排农业生产时，结合安排卫生工作；在检查农业生产时，要检查卫生工作；在总结农业生产时，要总结卫生工作，使生产和卫生工作紧密联系起来。只要我们坚持毛主席的无产阶级卫生路线，我们的工作就能前进，就能胜利，就能朝气蓬勃。

三、狠抓 爱国卫生工作是关系广大人民健康的问题，一定要抓紧，抓与不抓情况大不一样。在工作中，我们要狠抓重点、狠抓制度落实和狠抓典型。

(一)狠抓重点：“赤脚医生”应当根据生产和季节特点，结合生产队情况确定工作重点：水粪管理问题较多的大队，就应发动群众迅速改变面貌；在春初夏中，要广泛开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动；夏季着重预防肠道传染病和流行性乙型脑炎、疟疾等病；双抢季节注意防治中暑及稻田皮炎等。

(二)狠抓制度落实：就是要使爱国卫生运动成为经常化，树立以讲卫生为光荣，不讲卫生为耻辱的风尚。在经常性的卫生工作基础上，每年在春初夏中，充分发动群众，集中搞数次以除害灭病为中心的爱国卫生运动，定为常例。

(三)狠抓典型：要树立先进，及时总结经验，及时推广，开展比学赶帮活动，把爱国卫生防病工作不断推向前进。

第三节 让群众掌握防病知识

“革命战争是群众的战争，只有动员群众才能进行战争，只有依靠群众才能进行战争。”根据毛主席教导，只有充分发动群众，普及卫生教育，让群众掌握防病知识，才能真正做到预防为主。现将防病的一些基本知识简要介绍于下。防疫部分见“传染病”章，这里就从略了。

饮水卫生

饮水必须注意卫生，不清洁的饮水会使人得病。伤寒、急性胃肠炎、痢疾等各种肠道传染病以及蛔虫等寄生虫病，都可因水源被污染而引起传染。饮水卫生工作又称“水管”，包括：

【保护水源】

(一)在井水、河水、塘水边沿的厕所、粪坑、污水沟、牲畜棚、垃圾堆等等都能使水源受到污染，必须予以处置。一般粪坑、厕所等应距离水源十丈以外。

(二)井水：井壁宜用砖石砌叠，

井底铺小石块或粗砂。不论砖井、土井都应有井台、井盖(见图1-1)。

(三)河水、塘水：严格禁止在塘水和河水中倒垃圾，倒粪便，洗便桶，洗尿布。湖塘用水应将饮用湖塘与其他用途湖塘分开使用。河水可采用分段取水，上游取饮水，下游作用水，也可在离河岸适当的地方，开沙滤井(见图1-2)。

【饮水消毒】煮沸消毒是最好最简便的方法。此外经常应用的是氯制剂消毒。常用的氯制剂有漂白粉和漂粉精片或漂粉精粉。漂白粉有效氯含量在25~35%间。漂粉精片和漂粉精粉有效氯含量较高，约在60~70%左右。二者化学性质都不稳定，高温、光线、遇水都易使它们分解，故保存时应避光、防潮，严密封口放于阴处，现配现用。

(一)缸水消毒：

1. 直接加药法：使用漂粉精片，每担水加一片。如用明矾沉淀过的水，

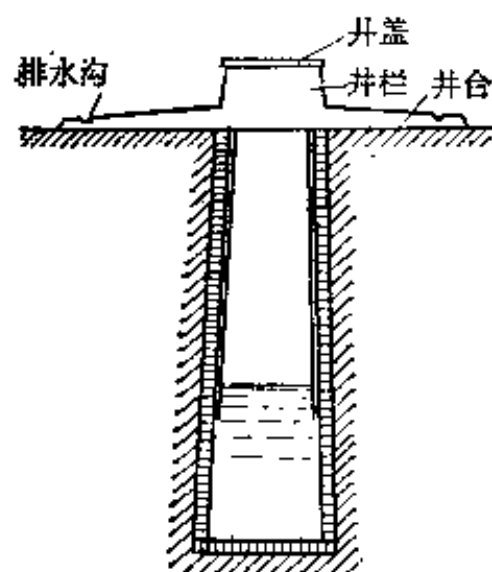


图 1-1 砖井示意图

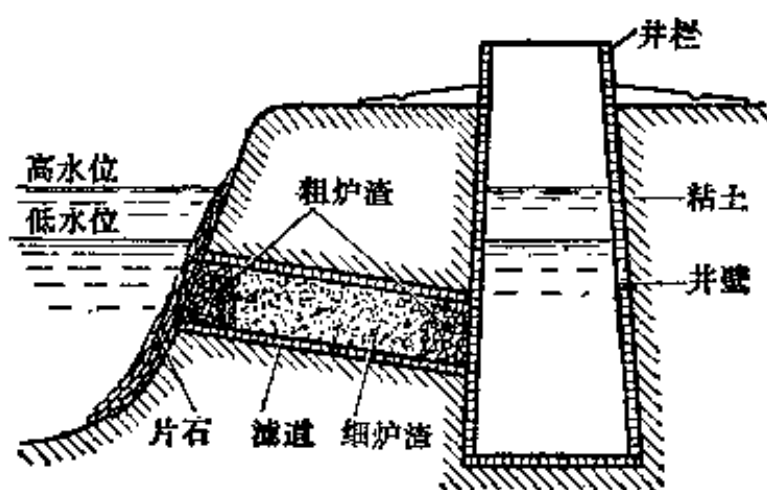


图 1-2 沙滤井

可每二担加一片。加药时，先将漂粉精片放在碗里研碎，加水调成糊状，倒入缸内搅动，半小时后饮用。使用漂粉精粉，则每担水加专用塑料小匙一小平匙。加明矾沉淀的缸水，一小平匙可消毒二担水。放药后搅匀，半小时后饮用。如用漂白粉消毒，可取新鲜漂白粉半斤，加水五斤充分调和，沉淀24小时后取上层清液，即成10%的漂白粉澄清液，装入有色的玻璃瓶或其它密封容器内备用。使用时，每担水加澄清液一匙(约10毫升)。经过明矾沉淀的每二担水加澄清液约10毫升。

2. 持续消毒法：

(1) 小瓶持续消毒法：取青霉素小瓶，去盖开口，用塑料线在瓶口打一小结，上缚一节小竹管(管内不打通)或一块轻质小木板作为浮子，与瓶口距离约5厘米处(见图1-3)。用药剂量见表1-1。用本法，缸内余氯可维持5~6天。

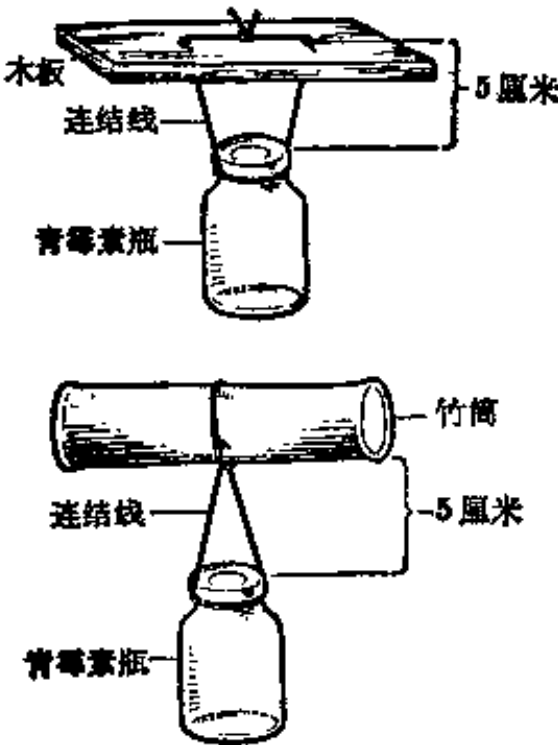


图 1-3 小瓶持续消毒

表 1-1 小瓶持续消毒加药剂量表

水缸容量(斤)	加入漂粉精粉(匙)
100	2
200	3
300	4
400	5
500	6

(2) 小竹管持续消毒法：取内径1.5厘米、长8厘米左右的小竹管(陈竹管最好)，中部用小铁钉烧红，通2~4个相对小孔(约2毫米如火柴头大小)，两端用棉花杆或软木塞等塞住。按每担水加二片的剂量，置入漂粉精片(如三担水加六片)。在管子内加水少许，塞紧木塞摇动几次，再将管子内水倒入缸中，然后塞紧木塞，放入缸中可使用3~5天。为防止竹管下沉，可在竹管上缚一段芦苇或小木条。

(3) 小塑料袋持续消毒法：用聚乙烯薄膜，高热粘合制成一端开口的小袋，袋长8厘米(约二根火柴杆长)，宽6厘米，在离袋底1.5厘米处开2~4个直径约0.5毫米小孔。使用时用药剂量见表1-2。加药后可放水少量，使其湿润，然后将袋口用棉线或塑料线扎紧，上系浮子，以防下沉。应用本法，每次能使缸水余氯约维持4~5天。

表 1-2 小塑料袋持续消毒加药剂量表

水缸容量(斤)	开孔数(个)	漂粉精片数(片)
150 以下	2	4
150	2	6
200	4	6
300	4	8

(二)井水消毒:

1. 一次加氯法: 一般土井加氯量为2~3毫克/升。消毒前先测定井水量, 然后根据井水量及井水加氯量计算出应加漂白粉量。一般水井都为圆筒状, 知道水深及水面直径即可知井水量。水深的测定可用绳子(下端系有重锤), 自井口慢慢沉入水中, 至重锤触及井底即停止。测量绳之受水浸湿与干燥分界线的长度, 即为井水深度。水面直径的测量: 可取二根等长的竹竿, 在中段用绳子扎住, 然后插入井中, 将竹竿之下端沿水面两侧张开, 并碰到井壁, 此时立即量出两竿顶端距离。收起竹竿, 在井外重新按上端距离张开, 竹竿下端距离即为水面直径(见图1-4)。如测定有困难, 也可大致估计直径。

井水量及应加漂白粉量可按下列公式计算:

井水量(立方米)

$$= \text{水深(米)} \times \left(\frac{\text{直径}}{2} \right)^2 \times 3.14$$

应加漂白粉量(克)

$$= \text{水量(立方米)} \times 12^*$$

若应用漂粉精粉, 则实际应用量应酌情减量。或可根据测得之水深及水面直径查表(见表1-3), 算出应加漂白粉后, 用汤匙取药(每匙约10克), 将漂白粉置于碗中, 加水少许, 调成糊状, 倒入井中震荡, 消毒半小时后就可使用。一般要求余氯在0.2~0.5毫克/升间。

2. 二节式竹筒持续消毒法: 用

*

$$12 = \frac{3(\text{以土井加氯量为3毫克/升计})}{0.25(\text{漂白粉有效氯一般以25\%计算})}$$

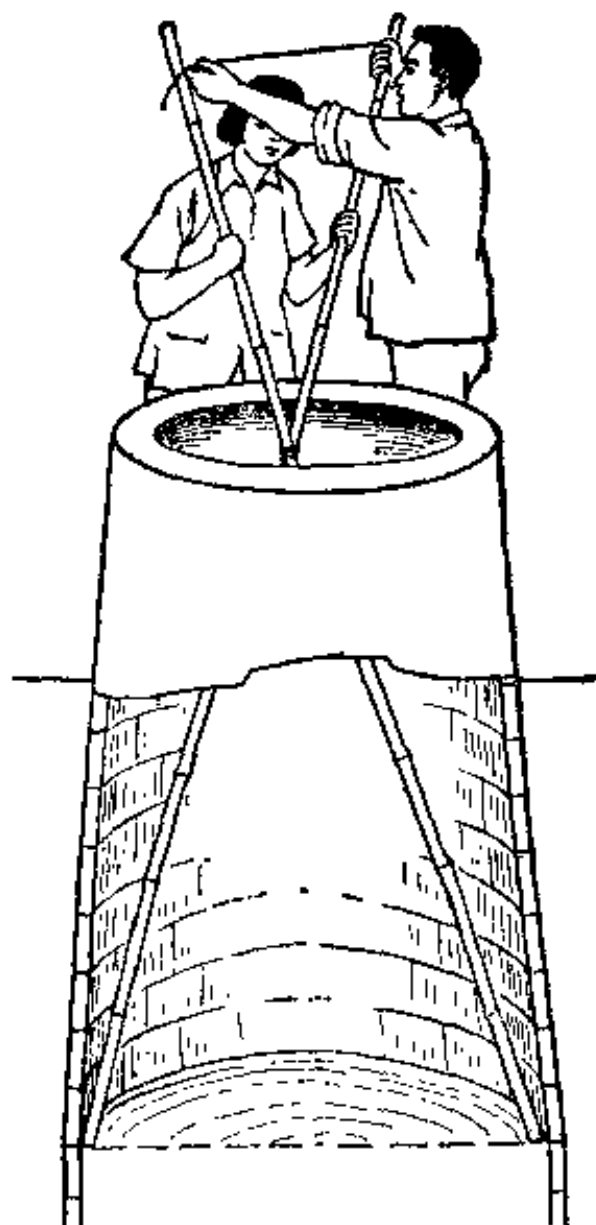


图 1-4 水面直径测量法

粗5~6厘米二节相连的毛竹筒一个, 上面一节作浮筒, 下面一节开一活门, 宽约4厘米作为加药用, 在活门下方打三、四个小孔(直径4毫米), 此处为氯溢出孔(见图1-5)。一般竹筒可装250~300克(半市斤左右)漂白粉, 使用时将漂白粉自活门装入筒内, 不必加水搅拌, 然后盖好活门并用塑料线扎住, 即可放入井中。随着吊水时的震荡, 氯气不断溢出。用水量多, 氯溢出量也增多。一次加药后, 一般可持

表 1-3 圆井井水消毒应加漂白粉量计算表

井直径 (市尺) 水深 (市尺) 用量 (克)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
1	0.5	1.5	2	3	4	5.5	7	8.5	10.5	12.5
1.5	1	2	3.5	4.5	6.5	8.5	10.5	13	16	19
2	1.5	3	4.5	6.5	8.5	11.5	14	17.5	21.5	25.5
2.5	2	3.5	5.5	8	10.5	14	17.5	21.5	26.5	31.5
3	2.5	4	6.5	9.5	12.5	17	21	26	32	37.5
3.5	3	5	8	11	15	20	25	30.5	37.5	44
4	3	5.5	9	12.5	17	22.5	28	34.5	42.5	50
4.5	3.5	6	10	14	19	25.5	32	39	48	56.5
5	4	7	11	15.5	21	28.5	35.5	43.5	53.5	63
5.5	4.5	7.5	12	17	23	31	39	47.5	58.5	69
6	4.5	8	13.5	19	25.5	34	42.5	52	64	75.5
6.5	5	9	14.5	20.5	27.5	37	46	56.5	69	82
7	5.5	9.5	15.5	22	29.5	39.5	49.5	60.5	74.5	88
7.5	6	10.5	16.5	23.5	31.5	42.5	53	65	79.5	94
8	6	11	18	25	34	45	56.5	69.5	85	100.5
8.5	6.5	11.5	19	26.5	36	48	60	73.5	90.5	106.5
9	7	12.5	20	28	38	51	63.5	78	95.5	113
9.5	7.5	13	21	30	40	53.5	67	82.5	101	119.5
10	8	13.5	22	31.5	42	56.5	70.5	86.5	106.5	125.5

注：1. 水深及井直径如与表中数值略有差异，可取近似值。

2. 方井可依本表应加漂白粉量增加百分之二十(即用 1.2 乘之)。

3. 水深超过 10 尺者，可分成两个数字找表，应加量为两数之总和。如 14 尺水深之井可找 6 尺及 8 尺两数合计。

续消毒 7~10 天左右，冬天更长一些。

无论缸水或井水，凡使用持续加氯法的，都应测定余氯以鉴定消毒效果，准确地控制加药数量和保持有效时间。水经过常氯量消毒后 20~30 分钟(夏季 20 分钟，冬季 30 分钟)，应测定余氯。一般加甲士立丁测定，也可直观测定(见表 1-4)。凡能嗅出氯臭而不具较强刺激时，表示余氯适量，

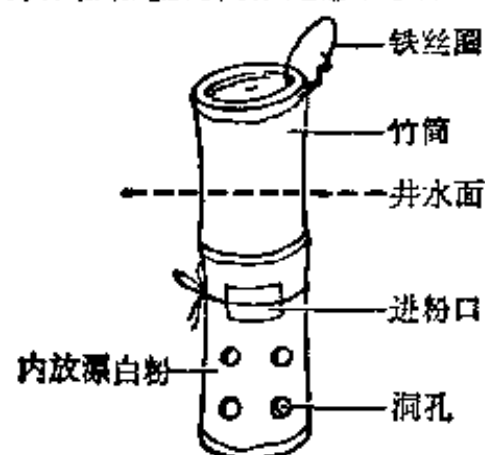


图 1-5 二节式竹筒持续消毒器

表 1-4 余氯测定法

水中余氯量 (毫克/升)	加甲士立 丁后颜色	氯臭程度
0.1	淡黄	仅可嗅出
0.2	黄色	容易嗅出
0.5	明显黄色	有明显氯味
0.7~1.0	深黄	氯味大
2.0 以上	棕黄	有强烈刺激性

约在 0.2~0.5 毫克/升间。若不易嗅出氯臭,表示余氯过低;若氯臭具较强刺激时,表示余氯过高,约在 0.7~2 毫克/升以上。

粪 便 管 理

人畜粪便是农业肥料,要搞好生产必须积肥,但一些传染病和寄生虫病,又可因粪便管理不善而通过害病的人和牲畜的粪便进行传播。粪管工作中历来存在两个阶级、两条道路和两条路线的斗争。我们一定要坚持毛主席革命路线,依靠群众,认真做好粪便管理工作,做到卫生为生产,生产讲卫生。

【粪管目的】

(一)减少肠道传染病及寄生虫病的传染机会,消灭苍蝇孳生环境。

(二)防止粪便散失,提高肥效,发展生产。

【粪管原则】 要坚持做到四定:

(一)定点集中:粪缸要在指定地点集中,应远离水源,不要太近宅基,但又要方便群众挑粪运粪。水上运送粪肥,注意不要污染水源。在集镇运粪时指定停靠码头。

(二)定人管理:生产队应设清洁员,负责清洁厕所、倒洗马桶等工作,

做好粪便管理。

(三)定期下药:可由小队卫生员或清洁员,每 3~5 天下一次灭蛆除蝇药物。

(四)定时用粪:应按一定时间俟粪便发酵后才能应用。

【粪便无害化处理】

(一)粪尿贮存法:把生粪贮在有盖的粪缸里或者放在有盖的不透水的贮粪池内,写上封存日期,可二缸(池)或几缸(池)交替使用。一般夏天半个月,冬天一个月左右,粪肥逐渐发酵,能把病菌和寄生虫卵杀死。有的地区在急需用肥的情况下,可在粪缸内加入 1~2% 氨水(含氮量 15%)或 0.5~1% 的石灰,过 2~3 天就可施用。在血吸虫流行地区,可把粪尿以 1:7 比例搅拌,利用尿产生氨杀灭血吸虫卵。夏季 3~5 天,冬季 7~10 天就可用以施肥。紧急用肥时,也可在每担粪尿中加入农药敌百虫 1 克(50 克等十一两)搅拌 24 小时后使用。

(二)泥封堆肥法:在远离水源与厨房的地方,选一块合适的空地。在上面先铺一层垃圾再浇粪,再铺一层垃圾再浇粪,这样一层层堆起来打结实,然后用泥封 2~3 寸厚。夏天 1 个月,冬天 2 个月,让它充分发酵,既能杀死虫卵病菌,又能提高肥效。

(三)无害化粪池:无害化粪池同一般粪池不同,它能使新鲜粪便发酵、杀灭虫卵,达到粪便无害化。它的结构、式样很多,有斜面式、二隔式等(见图 1-6)。粪池中分成头池、二池、三池。头池是粪便入口处,控制粪渣、虫卵沉淀。二池是过道,使粪便继续发酵。流入第三池的粪液是经过发酵作用后杀灭了血吸虫、钩虫、蛔虫等寄生

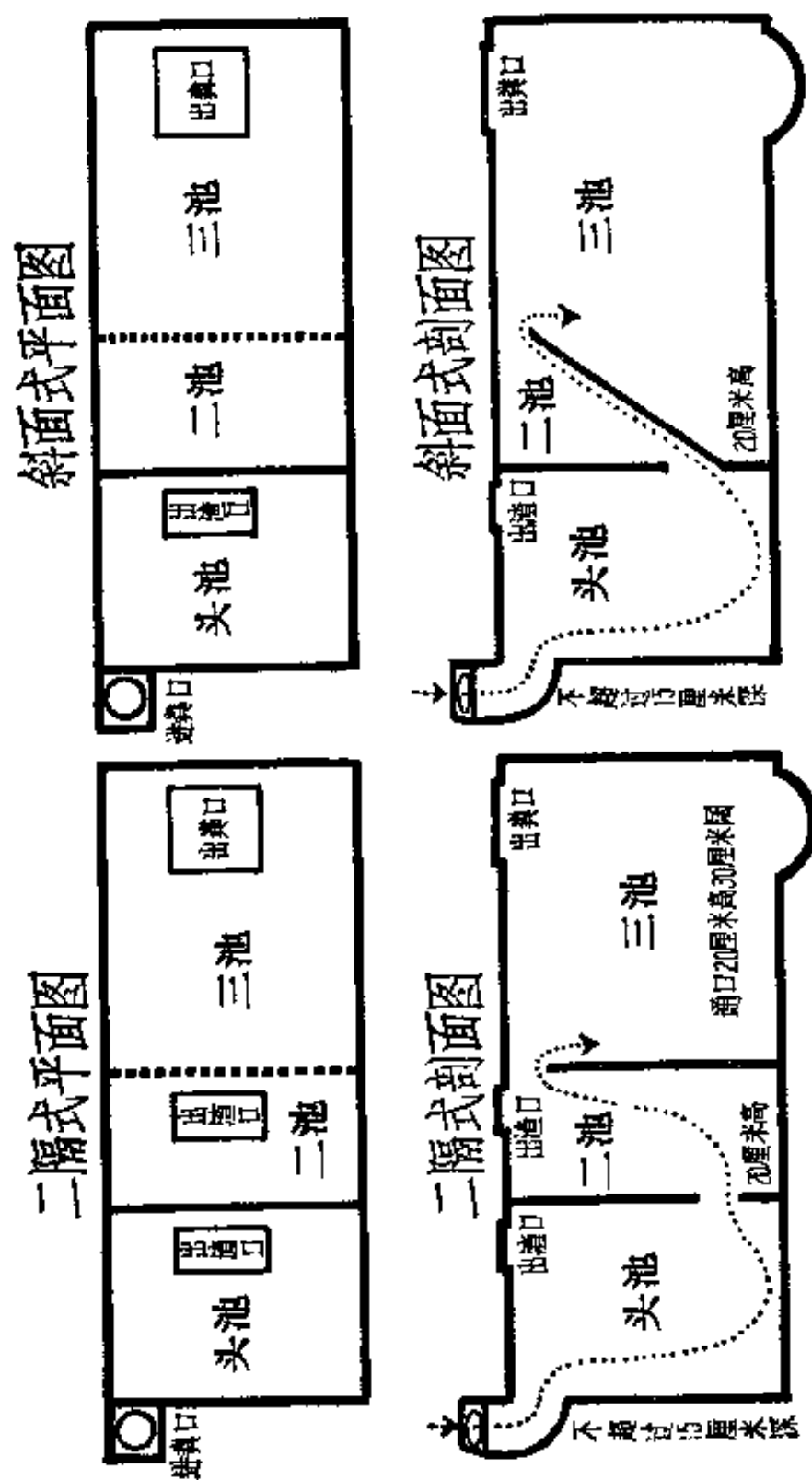


图 1-6 无畜化粪池模式图

注：本图根据上海金山县枫围公社用土办法建造的无畜化粪池绘制。各地可因地制宜，就地取材，创造多种形式。

虫卵的无害粪，随时可以使用。它与粪缸封存的區別是：一个是持续使用，一个是定期使用。建造无害化粪池必須遵照毛主席“自力更生”、“艰苦奋斗”的指示办事，批判“貪大求洋”的大少爷作风。有些地方发动群众，群策群力，创造了用“三合土”代替砖头，竹竿代替木料，废铁皮、竹筋代替钢筋，门板代替混凝土夹板等土办法，建造了简易有效、造价便宜的无害化粪池。

除 害

除四害的根本精神，是清洁卫生，人人振奋，移风易俗，改造国家。在毛主席革命卫生路线指引下，工农兵群众在除害斗争中积累了很多好经验，好办法。特别是我国疆域辽阔，各地都有大量野生杀虫植物，来源广泛，就地取材，使用方便。“赤脚医生”应注意发掘和总结群众经验，加以推广和提高，采取“土洋”结合的办法，同虫害作深入持久的斗争，把虫害彻底消灭。

灭 蚊

蚊子可传播多种传染病，主要的有疟疾、丝虫病和流行性乙型脑炎。蚊子的发育经卵→幼虫(孑孓)→蛹→成蚊。前三个阶段都生活在水里。一只母蚊，一生可产卵七次左右，每次产卵可上百，在炎热气候自卵发育成蚊仅7天左右，所以应该力争灭早、灭小、灭了。

【消灭孳生地】 可用填平坑洼，翻缸倒罐，堵塞树洞，消除积水，疏通沟渠，铲除杂草，水田养鱼等方法。

【灭孑孓】

(一)取辣蓼草鲜草一斤，加热水半斤，浸4小时投入粪坑或污水中，可

杀蛆或孑孓。

(二)取闹羊花茎叶捣碎，和水浸渍成水溶液，可以喷洒杀灭孑孓，也能灭蛆。

(三)毛茛全草切碎后投入粪坑或水坑，能杀孑孓及蛆。

(四)用0.1%敌百虫液喷洒(或泼洒)，每平方米用量40毫升。

【杀灭成蚊】

(一)捕捉：可在早晨与傍晚蚊子集中活动时，用网兜捕捉或用面盆涂肥皂水后粘杀。

(二)应用诱蚊缸：大缸、小罐、小髻都可使用。在缸(罐)内放水约缸(罐)容量的1/3~1/2，并加入适量敌百虫，水面上置些树叶、稻草。诱蚊缸应设置在阴暗多蚊的地方。

(三)辣蓼草、烟杆烧烟熏蒸，能杀成蚊。

(四)用0.1%敌百虫溶液或敌敌畏乳剂对室内进行喷洒(或泼洒)，敌百虫溶液5~10毫升/立方米，敌敌畏乳剂2~4毫升/立方米。

(五)敌敌畏熏蒸：以敌敌畏5毫克/立方米熏蒸杀灭成蚊。

灭 蝇

苍蝇为伤寒、霍乱、副霍乱、传染性肝炎、痢疾等多种疾病的传播媒介。蝇卵由幼虫(蛆)经蛹而为成蝇。一个母蝇一次能下一百到一百五十个卵，一生可下十次卵，1年大约能繁殖一万只以上。由于蛹、蛆冬天钻入泥土和粪堆过冬，第2年再大量繁殖，所以冬春是挖蛹灭蝇的大好时机，对全年降低苍蝇密度有重要关系。

【消灭孳生地】 大搞环境卫生，保持厕所清洁，加强粪便管理。

【灭蛆】

(一)结合积肥、造肥、泥封堆肥杀灭蝇蛆。

(二)草药灭蝇：能灭蛆的草药很多，除灭子牙(第9页)中介绍的外，再介绍二种如下：

1. 茶子饼：用5%浸出液，或每担粪加茶子饼2~4两，搅拌。能杀蛆，也可杀子牙。

2. 皂荚：将新鲜皂荚切碎，加水2倍，浸泡12小时，将浸出液洒于粪上，能杀蛆，也能杀子牙。

(三)用0.1%敌百虫溶液喷洒，每平方米粪面约需500毫升。

【灭蛹】发动群众对粪坑周围采用挖蛹或砸实地面等法消灭蝇蛹。

【杀灭成蝇】

(一)扑打：群众性扑打成蝇是简便有效的方法。

(二)百部一两熬汁，再和砂糖拌匀，诱杀成蝇。

(三)用0.1~0.2%敌百虫或0.1%敌敌畏毒饵诱杀。

(四)在苍蝇聚集场所，可以0.1~0.2%敌百虫溶液或敌敌畏乳剂喷洒，也可擦抹或泼洒。

(五)敌敌畏熏蒸灭蝇，见“灭蚊”节(第9页)。

(六)注意消灭越冬成蝇：越冬成蝇喜欢选择温暖、有食物的地方藏身。应仔细调查越冬蝇的停歇场所，采用扑打和六六六烟熏等方法消灭之。

灭 蟑 螂

蟑螂喜欢在厨房等存放食物的地方活动，不但贪吃食品，传染伤寒、结核、蛔虫等病，还能咬坏书籍、皮箱等，必须予以消灭。

【消灭孳生地】厨房及存放食物的地方，经常保持清洁，经常打扫。用石灰堵塞蟑螂躲藏繁殖的裂缝。

【捕杀蟑螂】

(一)断绝蟑螂食物：妥善收藏食物，清除食物残渣，可使蟑螂饿死。

(二)瓶捕：选择小口径的玻璃瓶，在瓶内存放香味食物，瓶口四周涂油，蟑螂诱进瓶后就无法爬出。

(三)毒饵诱杀：用硼砂一份，面粉一份，加少许糖调匀做成大如黄豆的丸子，撒在蟑螂经常活动的地方，可把蟑螂毒死。

(四)药物喷杀：结合消灭蚊蝇可以25%二二三或2%六六六药水喷杀。

灭 臭 虫

臭虫是一种吸血昆虫，由于扰乱人们睡眠，使人们降低生产劳动能力。一个臭虫由卵→幼虫→成虫仅需一个多月时间。臭虫繁殖力很强，发现臭虫如不及时彻底消灭，就可能在短期内出现很多臭虫。

臭虫对寒冷抵抗力强，但它怕热，一般用75°C热水即可烫死。

(一)搞好室内卫生，对墙炕裂缝用泥或石灰及含六六六的油灰抹严。

(二)开水烫：连续几次就能消灭干净。

(三)太阳晒：可把炕席、草垫、被褥等易于隐藏臭虫的物件，放在阳光下曝晒1~2小时，然后用棍条敲打，消灭落地臭虫。

(四)以闹羊花的草和花铺在席子下，可消灭臭虫。

(五)以杠板归(河白草)茎叶烟熏。

(六)煤油一斤,除虫菊四两,制成煤油除虫菊混合液,涂搽裂缝。

(七)用10%六六六粉剂直接喷洒裂缝。

灭 鼠

老鼠不但能传播鼠疫、稻热病(钩端螺旋体病)、恙虫病、流行性出血热、地方性斑疹伤寒等多种疾病,还要偷吃粮食,咬坏衣服,破坏堤坝造成灾害,危害很大。

【防鼠】妥善保存粮食和各种生熟食品,随时检查堵塞鼠洞,清除老鼠生活条件。

【灭鼠】

(一)可以采用鼠夹、鼠笼、水缸浮糠法、抽屉扣法、石板压法等。

(二)挖鼠洞:主要用于消灭田鼠、野鼠。凡是发现洞口下方光滑,洞外有土粒碎小的新土堆或在冬天洞口因老鼠呼吸挂有白霜时,这洞大多有老鼠,可顺洞挖鼠。

(三)药物毒鼠:常用的有磷化锌和安妥二种,可与蕃薯(或面粉)调拌均匀制成毒饵,放置适当地点。

(四)烟熏灭鼠:在仓库、下水道等处,可燃烧硫黄(每立方米约100克),使产生二氧化硫气体后,密封熏蒸5~8小时,即可灭鼠。

【附】灭蚤:跳蚤的主要宿主是老鼠,能传播鼠疫等疾病。

1. 桃叶,煮成浓汁,用喷射器喷洒床板、地面等处,或用漂白粉撒在床下、地面。

2. 夹竹桃鲜叶,切碎,撒在床下、地面。

3. 勤洗澡,勤换衣。

灭 钉 螺

钉螺是血吸虫的中间宿主。分布

在上质肥沃潮湿、水草丰茂、气候温暖、雨量充沛地区。灭螺工作必须加强领导,结合生产,全面规划,因地制宜,搞共产主义大协作,连续打几次大规模的歼灭战,才能收效。

【改造自然条件,消灭钉螺孳生环境】

(一)垦种灭螺:开垦种植,可使钉螺孳生环境不断破坏,钉螺在干燥、土埋、无草等因素的影响下可逐渐消灭。在湖滩沼泽地区的一些低洼沟浜处可结合火烧及药物灭螺。

(二)火烧:利用芦苇滩上冬季干枯的芦苇,进行火烧灭螺。火烧灭螺应注意先将芦苇割倒、晒干,每平方米需干草约二斤,而在积水潮湿处需用六斤。待晴朗气候有2~3级风时,在下风向放火点燃,可达到灭螺目的。烧芦苇季节宜在春季芦苇出芽前为好,这样火烧地区的芦苇不会减产,且能增产。火烧不到的地区,如积水坑、水沟泥缝等地要采用其它灭螺方法。

(三)土埋灭螺:可结合农村冬季兴修水利、开新沟填旧沟或掘坑时,把有螺地区连草带泥铲下四寸,埋入沟坑之中,深度必须在10厘米以上,铺上石灰和灭螺泥一起打实。也可结合积肥,如将有螺地段连土带草铲除一层约4厘米,铲下的草可以熏烧(烧火土灰)堆肥及沤肥(一担连泥草皮和石灰或畜粪一斤,外盖灭螺泥三寸压实,草灰腐烂发热可使钉螺死亡)。

(四)个别地区根据当地情况也有采用改水田为旱田的办法来消灭钉螺。

【药物灭螺】

(一)化学药物:所用药物很多,如五氯酚钠、石灰氮等。化学药物应在

当地血防部门指导下应用。

(二)植物药物:

1. 茶子饼浸杀,每亩 30~50 斤。
2. 闹羊花,每亩 10~20 斤。
3. 其他如泽漆、苦楝树、烟草叶等均可浸出药液进行喷洒杀螺,但必须注意切勿误食。

灭 虱

依据虱子寄生体位不同,把寄生于人的头发中的称之为头虱;寄生于人体内衣被褥的称之为体虱;寄生于阴毛部分的称之为阴虱。虱子不但咬人吸血,还能在吸血时传播回归热、斑疹伤寒等传染病。防生虱子最主要的是注意个人卫生,勤换衣服、勤洗澡。

【灭头虱】

(一)把头发加醋浸洗,使虱子卵容易脱落。再用竹篦把头发上的虱卵梳干净,然后用百部水煎液(百部一两放水二斤,煮沸半小时,过滤而成)擦头发,并以毛巾把头发包起来,过一夜就能杀死虱子。

(二)以 10% 二二三粉或 0.5% 的六六六粉一两,擦头发,用毛巾包头过夜,第 2 天用温水仔细洗头。

【灭体虱】

(一)勤洗澡,换衣,衣服被单可以沸水煮沸半小时。

(二)以百部 1 份,热水 10 份的百部水浸液浸渍衣服,可以防虱和灭虱。

(三)以 10% 二二三粉或 0.5% 六六六粉均匀地在衣服上散撒,7~10 天后同上法一次,可根除体虱。

【灭阴虱】洗澡后在阴毛部分撒上 10% 二二三或 0.5% 六六六粉,过夜后用肥皂水洗干净。

虱子体内有细菌,切勿以捉到的虱子用手指去挤,这样容易感染疾病,可放在火里烧掉。

化肥及农药中毒的预防

解放后,我国化肥工业及农药生产发展很快,有力地支援了农业生产。化肥、农药绝大部分对人畜无害,但有的也能危及人体健康,所以必须注意一定的安全卫生措施。

【化肥中毒的预防】

(一)化肥对人体的危害:我们常用的肥料中,一般都具有不同程度的皮肤刺激作用,特别是吸湿性强的,含游离酸较多的硝酸盐及酸性磷酸盐。而氮肥中的石灰氮,对人可有显著毒性。

化肥通常有皮肤刺激作用,但因接触皮肤较少或为时较短,一般可无症状出现,而在夏季则可引起皮肤潮红,剧烈刺痒,产生湿疹样皮炎,甚至可出现浅表溃疡。

石灰氮及磷肥粉末对于眼及呼吸道粘膜也可有刺激作用,引起红眼痒痛及咳嗽等症。

石灰氮的毒性主要表现为血管运动中枢和呼吸中枢的兴奋,患者可出现头部和上半身皮肤粘膜潮红,呼吸加深加快,心率加速及自觉头痛、头晕、烦躁等症。

(二)化肥中毒的预防:

1. 施肥时,宜穿长袖衣裤,戴帽及口罩。施肥宜取上风位置。劳动后洗手洗脸,清除化肥粉尘,注意个人卫生。

2. 追肥时不直接用手去抓,可用铲子、勺子、小瓢等工具。

3. 凡眼病、皮肤病及上呼吸道感

染患者，发病期间暂不宜参加有关接触化肥的农活。

4. 硝酸铵和硫酸铵具爆炸及猛烈助燃作用，应妥善贮藏，注意防火。

5. 很多化肥外表似食盐，放置应注有标记，以免误食。

【农药中毒的预防】

(一)农药的毒性分类：按农药毒性可分三类。

1. 基本无毒或低毒性的药剂：如硫酸亚铁、除虫菊、硫黄制剂及大部分土农药。

2. 有毒剂：如二二三、六六六和其他有机氯杀虫剂、鱼藤酮等。这类农药虽有毒性，但毒性不强，使用较安全，只在大量进入人体后才会引起中毒。

3. 剧毒剂：如有机磷杀虫剂1605、1059等，少量进入人体即能引起中毒，所以使用之前必须充分了解使用范围、对象，坚持集中使用，集中管理，加强预防，防止滥用、误用。

(二)农药中毒的预防：

1. 注意保管：各生产队要设置专人和农药专库保管农药。农药仓库应远离食堂、厨房、托儿所。库内不得放食物和日用品，不住宿人。农药购取、保管、领用制度要严密。有毒容器

要集中处理消毒。1605、1059盛器可用碱水、石灰水或草灰水浸泡7天后再作他用。药物分装不要随手倾倒，谨防沾污。

2. 个人防护：个人防护的重点，在于尽量减少沾染。在搬运、配制、使用时应穿长袖衣裤、鞋袜，戴口罩，不让皮肤和农药直接接触。在使用剧毒农药时可以油布脚罩防护下肢，也可在手足涂抹肥皂，加以防护。劳动完毕后应洗涤手脸，但要注意不要污染水源。

3. 劳动卫生：喷洒施布农药时，应站在上风向，顺风施药。两具喷雾机同时工作时，应有适当距离，避免相互影响。拌种时可将种子和药粉倾入有严密盖子的箱中，然后转动此箱。倾人和取出时，动作要轻、稳，减少药粉飞扬。

4. 谨防误食：有些农药如二二三为白色粉末，略有水果香味，极易误作面粉或发酵粉而误食，必须加强保管。喷过1605和1059的田间要插上标记，防止人畜进入。

5. 切勿误用：切勿将农药作医疗用，如将农药治疮、擦癣都可引起中毒。

第二章 怎样认识和治疗疾病

伟大领袖毛主席教导我们：“马克思主义的哲学认为，对立统一规律是宇宙的根本规律。”人体生活在自然界中，是始终处于对立统一之中的。人体内各器官、各系统之间，人体和外界自然环境之间，都保持着密切的联系，彼此互相斗争，互相依存，互相联结，互相制约。所以任何疾病的产生都有一定的条件和根据，只要有这种疾病的存在，人们就能在向它作斗争的过程中，逐渐地认识疾病产生的内因和外因，找到战胜它的方法。

在医疗实践中，必须突出无产阶级政治，用政治统帅业务。是用毛主席的唯物辩证法去指导医疗实践，还是

从主观想象出发，用静止的、孤立的、片面的形而上学观点去从事医疗实践，这是决定医疗工作成败的关键。唯物辩证法同形而上学在医学领域里的斗争，实质上就是两个阶级、两条道路、两条路线斗争在医学领域里的反映。我们一定要在这个斗争的过程中，自觉地运用毛主席的唯物辩证法去认识世界和改造世界，去认识自己和改造自己，去指导医疗实践，不断揭露和批判形而上学的错误思想，肃清它在医学领域里的影响，正确地认识和治疗疾病，促进中西医结合，创造我国的新医学、新药学。

第一节 怎样认识疾病

“认识的过程，第一步，是开始接触外界事情，属于感觉的阶段。第二步，是综合感觉的材料加以整理和改造，属于概念、判断和推理的阶段。”我们要认识疾病，必须遵照毛主席的这一教导，首先要接触外界事情，即接触

病人。也就是说，要以深厚的无产阶级感情，耐心、细致地对病人的情况作深入的调查研究，然后，根据调查所得的材料，进行综合、分析、判断、推理，得出对疾病的初步认识，做出初步诊断。

进行调查研究，掌握感性知识

认识疾病的第一步，就是要对病人的情况进行调查研究，掌握基本病情。“只有感觉的材料十分丰富（不是零碎不全）和合于实际（不是错觉），才能根据这样的材料造出正确的概念和论理来。”因此，在进行调查研究时，掌握材料必须全面和正确，不然，片面的和错误的材料就会造成错误的诊断。

医生用什么方法对病人进行调查研究呢？归纳起来，主要有二种方法：一是详细询问病史，二是仔细进行检查。

（一）详细询问病史：询问病史，是调查研究的第一步。询问病史的主要内容如下。

1. 主诉：病人就诊时诉说的主要症状（或体征）及出现的时期，叫做

主诉。例如，一个病人因为肚子痛来看病，已经痛了一天，这个病人的主诉就是“腹痛一天”。

2. 现病史：病人的主要症状，伴发症状，以及这些症状发生、发展和变化的过程及医疗经过，就是现病史。问清主诉之后，必须进一步问清现病史，才能有助于诊断。例如，上面的病例“腹痛一天”，根据主诉只能使医生想到胆囊炎、胰腺炎、阑尾炎等许多以腹痛为主要症状的疾病。如果进一步问清了病人的现病史是：在初起时出现中上腹部疼痛，持续性，有时一阵阵加剧，隔数小时后疼痛转移到右下腹部。除腹痛外，还伴有发热、恶心。根据这样的现病史，就可以考虑这个病人很可能是患“急性阑尾炎”。

3. 过去病史：了解病人过去的健康情况，对诊断和治疗也往往是很重要的。例如，一个病人突然跌倒和昏迷，如果过去有长期和严重的高血压病，就很可能是中风。即使目前的疾病和过去的疾病没有直接联系，也应当对过去的疾病有所了解，这样有利于全面考虑治疗。例如，病人患高血压病，如果过去有胃溃疡病史，就应当避免给病人服利血平，因为利血平可能引起溃疡病发作。

此外，对病人的生活情况和周围环境，女病人的月经和生育情况，婴儿的喂养情况以及直系家属的健康状况等，必要时也应详细了解。

病人叙述病史，可能会很零乱，可能会将重要的症状遗漏，而片面的和错误的病史会造成诊断上的严重错误。例如，有的患右下大叶性肺炎的病人，起病时以右上腹疼痛、怕冷、发热为主要症状，咳嗽并不严重，因而就

诊时只讲右上腹疼痛、怕冷、发热，而将咳嗽遗漏，如果医生没有详细询问，就容易将这个右下大叶性肺炎误诊为“急性胆囊炎”。因此，询问病史时要耐心、要抓住病人就诊的主要痛苦，逐步深入，力求全面了解。

(二) 仔细进行检查：进行仔细的检查，是医生对病人进行调查研究的第二步。检查的方法包括体格检查和实验室检查。

1. 体格检查：体格检查就是医生利用自己的眼、耳、鼻、手等器官及简单器械(如听诊器等)对病人进行检查。体格检查的方法，中医称望、闻、问、切，西医称望、触、叩、听，两者实有许多沟通之处，现综合介绍如下：

(1) 望诊：用眼睛观察病人，例如病人的体型、精神、面色、舌苔、皮疹、局部有否畸形及肿块等。

(2) 触诊：用手摸局部情况，例如检查肝脾及肿块，局部压痛、肌紧张、语颤、心尖搏动等。中医的脉诊也属触诊的范畴。

(3) 叩诊：用手叩击病人局部，根据声音回响推测内部情况，例如叩肺、叩心浊音界、叩移动性浊音。或叩击局部观察有否疼痛，例如叩击肾区、胆囊区等。

(4) 闻诊：闻诊包括听诊和嗅诊两种。听诊就是直接听病人的声音和用听诊器听病人的心肺等。嗅诊就是用鼻嗅病人发出的特殊气味。

进行体格检查必须仔细和正确，粗枝大叶的检查和错误的检查结果，都会造成错误的诊断。例如一个急性阑尾炎病人，就诊时主诉腹痛、腹泻、呕吐，如果医生没有仔细检查病人右下腹的压痛和反跳痛，就可能将这个

急性阑尾炎病人误诊为急性肠胃炎。

2. 实验室检查和特殊检查：化验血液、大便、小便，放射线检查，直肠镜检查，各种穿刺检查等，也是对

病人进行调查研究的方法，这些检查需要较多的设备条件，因此，只有在必要和有设备条件的情况下才考虑应用。

综合感觉材料，作出初步诊断

对病人进行调查研究所获得的材料，不管怎样丰富，也只是感性认识。“要完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考作用，将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫，造成概念和理论的系统，就必须从感性认识跃进到理性认识。”

一种疾病可以出现多种症状，甚至出现假象；同一个症状又可由不同的原因引起。因此，在分析病情时必须注意抓住重点，必须注意识别假象，不然就不能做出正确诊断。例如，一个病人就诊时主诉腹痛、腹泻十多小时。起病时上腹部疼痛，约2小时后腹泻，大便水样，共六、七次，呕吐食物，发热，头痛。上腹部疼痛于起病约数小时后转移到右下腹。检查结果：体温摄氏38°左右，右下腹有局限性压痛和反跳痛。这个病例，在听到病人腹痛腹泻的主诉后，很容易想到是急性肠胃炎。但是，进一步问清了病史之后，病

人右上腹部疼痛向右下腹转移，右下腹有局限性压痛和反跳痛，这是急性阑尾炎的具有特征性的症状和体征，应当抓住这个重点，诊断为急性阑尾炎。至于水泻，少数急性阑尾炎病人可以见到，但一般不会成为病人的主要症状。这个病人以腹泻为主诉，因而腹泻对这个病例也可以说是假象，如果不识破它，就会引导出错误的诊断，将这个病人误诊为急性胃肠炎。

一个病人同时可以患两种以上疾病，一种疾病过程中也可能出现种种变化。因此，在分析疾病时，除要抓住重点外，还要有联系的观点和发展的观点。例如，一个病人患流行性感，如果经过几天的治疗，发热不退，咳嗽加重，就应当想到并发肺炎的可能，必须进一步仔细检查，以得出新的诊断。

总之，要正确地认识疾病，必须以毛泽东思想为指导，首先要对病情进行详细的调查研究，并根据疾病的客观规律，对病情进行深入分析。只有这样，才可能得出正确的诊断。

第二节 怎样治疗疾病

认识疾病是为了治疗疾病。治疗方案是在诊断的基础上产生的。毛主席教导我们：“这时候的精神、思想（包括理论、政策、计划、办法）是否正确地反映了客观外界的规律，还是没有证明的，还不能确定是否正确，然

后又有认识过程的第二个阶段，即由精神到物质的阶段，由思想到存在的阶段，这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去，看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。”医生对一个病人作出的诊断和

治疗方案是否正确，也要经过实践的检验。一般说来，如果诊断和治疗方案是正确的，就能收到较好的疗效；相反，就要遭到失败。当然，有些疾病到目前为止还没有找到有效的治疗方法，虽然诊断是正确的，仍然不能获得满意的治疗效果。如果在治疗中不能获得预期的效果，就应当重新对病情进行调查研究和分析，找出原因。在治疗过程中，部分修改甚至重新制定治

疗方案，是常有的事。

治疗的方法很多，新针、草药、推拿、物理疗法、体育疗法、中西药物和外科手术等都可治病，它们各有自己的特点和治疗范围。不管用什么疗法，在治疗过程中都应当突出无产阶级政治，用毛泽东思想作指导，特别是要用毛主席的《实践论》和《矛盾论》作指导。

突出无产阶级政治，坚持四个第一

伟大领袖毛主席教导我们：“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。”“赤脚医生”是贫下中农自己的医生，是为阶级兄弟健康服务的，是为社会主义生产服务的，是为巩固无产阶级专政，加强战备、保卫祖国服务的，必须正确认识全心全意为人民服务这个根本问题，把全心全意为人民服务作为自己的毕生职责。坚持活学活用毛泽东思想，以白求恩同志为光辉榜样，发扬不为名、不为利，“一不怕苦，二不怕死”的革命精神，做到“完全”、“彻底”地为人民服务，并经常批判资产阶级医疗思想。

政治是统帅，是灵魂。在防治疾病中，必须高举毛泽东思想伟大红旗，突出无产阶级政治，用政治统帅业务，批判“不治之症”及“技术第一”的资产阶级思想。只要以毛泽东思想为指导，敢于实践，从实践中找出其主要矛盾和规律性的东西，任何疾病都是可以被认识，可以找到战胜它的方法，变“不治之症”为可治之症的。

伟大领袖毛主席指出：“**武器是战争的重要因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物。**”在与疾病

作斗争中，必须首先坚持四个第一，充分发挥人的主观能动作用。技术、设备等条件固然重要，但不是决定的因素。能不能为病人治好疾病，最重要的是看他有没有一颗无限忠于毛主席，全心全意为人民服务的红心。有了这颗红心，就能急贫下中农所急，想贫下中农所想，处处突出一个“公”字；有了这颗红心，再大的困难也能战胜，再差的条件也能克服，再难的技术也能掌握，什么人间奇迹也可以创造出来。林副主席教导我们：“**人民群众掌握了毛泽东思想，就变得最聪明，最勇敢，就能发挥无穷无尽的力量！**”在伟大的无产阶级文化大革命中，卫生战线涌现了大鬲新人新事和先进事物，创造了许多震惊世界的奇迹。中国人民解放军 4800 部队全心全意为人民服务的先进卫生科，无限忠于毛主席的无产阶级卫生路线，向所谓“不治之症”宣战，在设备和技术条件都较差的情况下，给贫农女社员成功地切除了九十多斤重的大肿瘤；上海崇明县“赤脚医生”在简单的设备条件下，给贫下中农社员切除了四十三斤重的腹部肿瘤。这都是突出无产阶级政治，毛泽东

思想武装了人的结果。

在医疗过程中，必须重视内因作用，创造合理条件，达到理想效果。对病人要进行过细的政治思想工作，充分发挥病人主观能动作用。反对见病不见人，见人不见思想的资产阶级的医疗观点。广大工农兵有高度的政治觉悟，他们有着坚强的革命斗志，战胜了危重疾病的生动事例是很多的：麦贤得同志在大脑受到严重创伤时，仍坚守岗位，直到战斗的胜利；一位青年女工同志在烧伤面积达98%，三、四度达88%的严重威胁下，用毛泽东思想压倒一切困难，战胜了疾病；一位飞行员怀着保卫毛主席、保卫社会主

义祖国的赤胆忠心，以顽强的革命意志，战胜了癌症重上蓝天。这些光辉事例，都雄辩的证明了毛主席“外因通过内因而起作用”的英明论断。

因此，医务人员在防治疾病过程，必须帮助病人活学活用毛泽东思想，树立革命人生观，坚强地战胜疾病，发扬革命英雄主义精神。注意做深入细致的思想工作，抓好病人的活思想，随时帮助病人克服各种不利于同疾病作斗争的思想，从而促进机体各组织的机能旺盛，调动和增强人体内部的抗病因素。只有医生与病人在毛泽东思想统帅下，密切配合，共同战斗，才能取得最好的防治效果。

树立整体观念，反对孤立片面

“一切客观事物本来是互相联系的和具有内部规律的”。人体是个有机整体。人体任何一部分发生疾病，都和整体密切相关。因此，在治疗疾病的时候，必须反对只见疾病，不见思想，只见局部，不见整体的形而上学观点。疾病和思想的关系，前面已经谈过了。局部和整体的关系也是非常明显的。例如，一个病人腿上生了一个疮，局部红、肿、热、痛，这看来象是局部的疾病。但是，这个病人又感到怕冷、发

热，这就说明这个局部的疮引起了全身反应。在治疗的时候，单纯局部敷药是不够的，是不容易治好，而且还有可能发展成败血症，根据病情应同时给病人服清热解毒的中、草药或用抗菌药，这样才能很快将病治好。再如烫伤是局部的疾病，但是局部烫伤可引起休克，如果医务人员头脑里没有整体观念，在处理烫伤时不注意全身情况，就可能出问题，不可不引起十分注意。

深入事物本质，治病必须治本

“我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。”治疗疾病必须遵照毛主席的这一教导。大家都知道“头痛医头，脚痛医脚”是不对的。为什么不对呢？就是因为错在违反了毛主席的这一教导，只看到疾病的现

象就动手治病，没有深入抓住疾病的本质，没有针对引起头痛和脚痛的原因进行治疗。一个症状，只是一种现象，它可以由许多不同的疾病引起。找出了引起这个症状的疾病，就是深入了事物的本质。发热是个很常见的症状。引起发热的疾病也很多，不找出原因，一律用退热药，那是不行的。必须

找出发热的原因，是某种细菌感染引起，就采用抗某种细菌的药物和采用增强人体消灭细菌的能力的方法进行

治疗。这就是深入了事物的本质。这样的治疗就是治本。

抓住主要矛盾，注意主次缓急

疾病过程中的矛盾是错综复杂的，因为一个人身上可以同时得几种病。就是一种病的过程中，其内部也存在着不断变化的矛盾。“任何过程如果有多数矛盾存在的话，其中必定有一种是主要的，起着领导的、决定的作用，其他则处于次要和服从的地位。”“矛盾着的两方面中，必有一方面是主要的，他方面是次要的。其主要的方面，即所谓矛盾起主导作用的方面。”尽管疾病过程中的矛盾是错综复杂的，只要我们能够抓住主要矛盾和主要的矛盾方面，我们就能分辨疾病的主、次、缓、急，正确地治疗疾病。中国人民解放军沈阳部队某部卫生人员治疗聋哑所获得的惊人成绩，就是活学活用毛泽东思想的结果。他们正确地分析了聋与哑的关系，认为聋是聋哑的主要矛盾。因为耳聋，听不到声音，所以也就学不会讲话。聋治好了，听到声音，就能逐步学会讲话。中国人民解放军某部军医治疗神经衰弱获得显著疗效，也是活学活用毛主席的哲学思想的生动例子。他们认为，人们白天精力充足，晚上睡眠，这是正常的兴奋

和抑制现象。神经衰弱患者的问题，就在白天该兴奋而兴奋不起来，晚上该抑制又不能很好抑制，因而破坏了神经活动的正常规律。兴奋和抑制是一对矛盾，兴奋是起主导作用的，因为休息是为了工作。因此，治疗也应该在兴奋方面想办法。在科学分析的基础上，他们大胆打破了用镇静安眠药治疗神经衰弱的旧框框，采用增强病人兴奋的方法。上午对病人进行治疗，使白天精力充足，很好工作，这样，晚上就能诱导出适当的抑制，自然睡眠，很快恢复了神经活动的正常规律，使疾病获得痊愈。这二个例子，说明抓住主要矛盾和矛盾的主要方面的重要性。此外，还应当注意，主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面，都是可以互相转化的。例如聋哑病人，聋是主要矛盾。当经过治疗，听力恢复之后，哑就转化为主要矛盾，治疗重点就要放在哑方面，强调和做好语言训练。因此，在治疗疾病过程中，必须注意疾病的发展变化，并根据这种变化，改变和制定新的治疗方案。

区别不同情况，因时因地制宜

世界上一切事物，都是与外界具体环境密切联系的。因此，在分析事物的时候，必须根据事物的具体环境，即时间、地点、条件，进行具体分析。“马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析

具体的情况。”认识疾病也是一样。认识和治疗疾病，除了认识一般的规律之外，还要注意特殊的情况，注意不同的人、不同的时间和不同的地点的差异。例如，同样应用发汗药，必须根据病人的体质和不同的季节选择不同的

发汗药或不同的剂量。体质好的剂量大些,体质差的剂量小些,以免出汗过多造成虚脱。冬季用发汗药可以选择作用强的如麻黄、桂枝,夏季用发汗药就适宜于选择香薷。再如治疗烫伤,寒冷的季节应当考虑包扎,炎热的季节

就应考虑暴露。

总之,在治疗疾病过程中,必须以毛主席的唯物辩证法作指导。这样,才能使我们的医疗实践“有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。”

坚持土洋并举,贯彻中西结合

遵照毛主席“团结新老中西各部分医药卫生工作人员”的指示精神,中西医应当团结合作,运用近代科学的知识和方法来整理和研究中医中药,按照“古为今用,洋为中用”、“推陈出新”的方针,取其精华,去其糟粕,取长补短,互相补充,中西医结合,创造我国统一的独创的新医学、新药学。这种崭新的、先进的医学,集古今中外医学精华的大成,可以更好地保障广大劳动人民的健康,适应我国社会主义革命和社会主义建设对医学的要求,同时对于世界医学的发展,也是一个重大的贡献。全国解放以来,特别是无产阶级文化大革命以来,通过用唯物辩证法指导的中西医结合,已经创造出一些比单用中医或西医好得多的新疗法,解决中医或西医所不能解决的问题。例如,在治疗骨折中,吸取了西医正确复位、中医小夹板固定的长处,恰当地解决了骨折部位的固定和伤肢的早期活动、局部和整体的对立统一关系。这样,一方面保持了局部的相对固定,有效地控制了对骨折断端不利的活动;另一方面,又为整个肢体和全身的活动创造了条件,使肢体在骨折愈合期间进行适当的功能锻炼,充分发挥了活动对骨折愈合有利的作用,因而取得了骨折愈合快,治疗时间短,功能恢复好,并发症少的显

著效果。

目前正在我国医学界热烈展开的新医疗法和应用土方土法、单方草药防病治病的群众运动,对于落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针,具有十分重要的意义。同时,这些疗法有利于促进中西医结合,创造我国的新医学、新药学。用“一根针”、“一把草”治病,效果好,既经济,又方便,深受劳动人民欢迎。有利于保护劳动人民健康,使贫下中农有病都能迅速、及时、普遍地得到有效的治疗,对于巩固深受贫下中农欢迎的合作医疗制度,起着巨大的作用。中草药可以就地取材,就地加工,取之不尽,用之不竭,在战时是打不烂的天然药库。用“一根针”、“一把草”治病,对各种常见病多发病已有很高的疗效,对资产阶级医学“权威”所武断说成“不治之症”的一些疾病,也已取得了不少的疗效。因此,为了更好地落实毛主席对医疗卫生工作的一系列重要指示,更好地全心全意地为劳动人民服务,更好地开展防病治病工作,我们就一定要坚持土法上马、土洋并举,一定要贯彻中西结合,运用毛主席的唯物辩证法,把中国医药学和西医学的精华有机地结合起来,坚持“独立自主、自力更生”的方针,走我国自己医学发展的道路,创立一个崭新的新医学、新药学。

第三章 中医是怎样看病的

中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的经验总结。它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富经验和理论知识。它是一个伟大的宝库，必须继续努力发掘，并加以提高。但是，长期以来，叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在卫生系统的代理人鼓吹“洋奴哲学”、“爬行主义”，胡说什么“中医不科学”、“西医必然要代替中医药”，竭力推行为少数城市老爷服务的修正主义卫生路线，百般排斥、扼杀中医中药，严重阻碍了我国医疗卫生事业的发展，犯下了滔天罪行。我们必须高举毛泽东思想伟大红旗，彻底清算刘贼散布的流毒，继承和发扬祖国医药学中的精华，使之更好地为社会主义革命和社会主义建设服务。

中医看病，首先是用望、闻、问、切四种方法了解病情；然后，根据中医的基本理论，将四诊所得的材料进行综合分析，确定“病症”和治疗方法。这叫做“辨证施治”。现从临床需要出发，将中医四诊和辨证施治的主要内容，作一简要介绍。

中医看病，首先是用望、闻、问、切四种方法了解病情；然后，根据中医的基本理论，将四诊所得的材料进行综合分析，确定“病症”和治疗方法。这叫做“辨证施治”。现从临床需要出发，将中医四诊和辨证施治的主要内容，作一简要介绍。

第一节 四 诊 要 点

问 诊

问诊应当直接问病人。如果是幼儿和昏迷病人等，则应当问了解该病人病情的人。

问诊的内容，首先要问清楚主要症状和同时出现的其他症状，以及这些症状出现的日期与发展变化过程，还要问清过去的有关病史，特别应当注意问清下列一些情况。

一、寒热 一般说，初起发热、怕冷是表证；发热、不怕冷而出汗、口渴是里证。经常怕冷而无发热是阳虚；长期下午颧面红、有低热、掌心热是阴虚。

二、汗 一般说，发热不高、怕风、有汗是表邪较轻；发热、怕冷、无汗是表邪较重。不发热而出汗叫自汗，是阳虚。睡着后出汗叫盗汗，是阴虚。

三、大小便 大便秘结，干燥难解，多是实证、热证。大便稀薄有不消化食物，多是虚证、寒证。小便短少黄赤，多是实证、热证。小便清长色白，多是虚证、寒证。

四、饮食口味 喜欢热的饮食，多是寒证。喜欢冷的饮食，多是热证。口苦，多是热证。口淡、口甜、口腻，多是有湿。

五、月经 对于女性病人，应当注意问月经。月经提前，量多，色鲜红，多是热证。月经延期，色暗紫，多是寒证。月经延期，色淡，多是血虚。月经量少有块，经前腹痛，多是血瘀。

望 诊

医生利用自己的眼睛观察病人叫做望诊。望诊的内容很多，病人的精神、形态、面色、舌苔以及全身各部分

出现的异常现象,都要通过望诊获得。现将望诊的主要内容作一简要介绍。

一、望神 望神就是观察病人的精神好坏。病人两眼灵活有神,精神不衰,表示疾病还不十分严重。病人两眼呆板无神,精神萎靡,表情淡漠,常表示病情严重,多是虚证,应当引起特别注意。

二、望色 观察病人皮肤指甲的色泽,特别是面部,叫做望色。

(一)面色潮红:多是热证(实热或虚热)。

(二)面色苍白:多是虚证,特别是血虚。

(三)面色萎黄:多是虚证,特别是脾胃虚。

(四)面色晦暗:多是虚证,特别是肾亏。

(五)黄疸:病人眼白发黄,严重的全身皮肤也发黄,多是湿热。

三、望舌 观察舌苔和舌质的变化叫望舌,是中医诊病的重要内容。

(一)舌苔:正常人舌上有薄薄的一层白苔。生病后舌苔的变化表现为舌苔增多增厚和颜色变化。

1. 白苔:多是寒证。

2. 黄苔:多是热证。

3. 腻(音呢)苔:舌苔增多而且看上去有粘糊的感觉,叫做腻苔,多是有湿。白腻是寒湿,黄腻是湿热。

4. 黑苔:黑苔多见于重病。舌苔焦黄、舌根黑,多是热盛。

5. 染色苔:由食物的颜色而使舌苔发生色泽变化(如吃过橄榄后舌苔变黑),有些药物也会出现黑苔,无诊断意义。

(二)舌质:正常人舌质淡红色,湿润,转动灵活,能自由伸出口外。

1. 舌淡:舌质的颜色比正常人淡,是虚证,多见于血虚和阳虚。

2. 舌红:舌质的颜色比正常人红,是热证或阴虚。舌红而苔黄是实热。舌红而无苔或舌苔剥落是阴虚。深红者多是热盛伤阴。

3. 舌紫:舌紫色,或有紫斑,多是血瘀。

4. 舌红起刺:多是热证。

5. 舌干燥:多是热盛伤阴。

6. 舌头强硬:多见于肝风。

闻 诊

闻诊包括用鼻嗅气味和用耳听声音。

一、嗅气味 一般说来,病人口中发出很浓的气味如腥、臭等,多是热证。同样,病人的排泄物如痰、汗、大便、小便、白带等特别腥臭,也多是热证。

二、听声音

(一)语言:语音低微多是虚证,语音响亮多是实证。

(二)呼吸:呼吸浅表而声音微弱,多是虚证。呼吸声粗多是实证。

(三)咳嗽:咳声低微,无力咳嗽,多是虚证。咳声响亮多是实证。

切 诊

切就是摸和按的意思。切诊包括按脉和摸体表。

一、切脉(诊脉) 切脉是中医诊断疾病的方法之一,过去被讲得非常神秘,说成是中医诊病的唯一方法,什么病都能从诊脉得出诊断。这种看法是非常片面的。我们必须纠正这种错误的看法,只有全面地观察、分析和综合病情,才能作出正确诊断。

(一)切脉的方法:病人手掌向上平放,医生以食指、中指和无名指顺序放在病人腕部桡动脉上,按察脉搏跳动情况。切脉前须让病人休息一会。

(二)脉象:正常人的脉搏,一呼一吸之间四次,每分钟约 60~80 次(古代没有钟表,所以医生以自己的呼吸来计数病人的脉搏,切脉时,医生必须定心调整自己的呼吸),节律均匀。小儿脉搏较成人快。患病时脉搏变化,常见的有如下十种:

1. 浮脉:手指轻按就感到,这种脉多属表证。

2. 沉脉:轻按不明显,重按才感到,这种脉多属里证。

3. 迟脉:脉搏慢,一呼一吸之间二、三次,这种脉多属寒证。

4. 数(音索,快的意思)脉:脉搏快,一呼一吸之间六、七次,这种脉多属热证。

5. 弦脉:脉搏硬而有力,好象按在拉紧的弓弦上,这种脉多属肝病或

寒证。

6. 滑脉:脉搏流利,象珠子滑过去一样,这种脉多属有痰。怀孕时也有见到这种脉。

7. 濡脉:脉浮而较软较细,这种脉多属有湿。

8. 细脉:脉来细小如线,这种脉多属虚证。

9. 洪脉:脉来如波涛汹涌,多属热证。

10. 结代脉:脉律不齐,动而中止,多属心病。

二、摸体表

(一)摸皮肤:皮肤灼热,多是实证、热证。皮肤冷而汗多,多是虚证、寒证。

(二)摸手脚:手脚冷,多是虚证、寒证。

(三)摸腹部:腹部胀痛,以手按压下去更痛而抗拒,多是实证。按压反觉舒服,多是虚证。

(四)摸脓肿:见“外科感染”节。

第二节 辨证施治

医生调查了病人详细的病情后,用中医的基本理论,对病情进行综合、分析、推理、判断,以得出疾病原因、部位、性质、深浅的结论,决定治疗方法,叫做辨证施治。

“辨证”有以下几点:

一、辨别疾病的“病邪” 一切破坏人体正常功能,引起疾病的因素,不管是从体外侵入的还是体内生成的,都叫做“病邪”。风、寒、湿、痰、热(火)、暑、燥、虫等,都是病邪。每种病邪致病,都表现出一定的证候。例如,湿邪致病有胸闷,胃口不好,口中淡腻,舌

苔腻等证候。

二、辨别疾病的部位 不管哪一种疾病,总是发生在人体的某一部位。如在气,在血,或在某一脏腑。一定部位的疾病也都表现出一定的证候。脏腑气血的辨证,就是通过分析证候,辨别疾病在人体哪一部位。例如,肺病有咳嗽、咯痰、咳血等证。

三、辨别疾病的性质 祖国医学中常用表里、寒热、虚实、阴阳等名词来概括疾病的不同性质,称为“八纲辨证”。八纲中的表里是指疾病部位的深浅;虚实是指邪正盛衰;寒热是指疾

病的属性；阴阳是指疾病的类别。八纲辨证必须通过“病邪辨证”与“脏腑气血辨证”后才能对疾病作出恰当的判断。

四、辨别热性病 所谓热性病是

指由外邪引起的，以发热为主要证候的一类疾病。热性病的辨证，就是通过证候分析，了解它的发生、发展过程，掌握热性病的一般规律和相应的治疗方法。

一、八纲辨证施治

虚 实

虚实概念是在中医学中“邪正”理论的基础上形成的。凡是正气不足，抗病力弱的，都称为虚证。病邪炽盛，人体抗病力强的，称为实证。治疗方法，实证以祛邪为主，虚证可以扶正为

主。如发表、攻下、祛风、散寒、化湿、清热、行气、消痰、化痰、逐水、消食、驱虫等方法，都应用于实证；如益气、补血、养阴以及健脾、补肾等方法，都应用于虚证。虚证和实证主要症状鉴别见表 3-1。

表 3-1 虚证和实证简表

辨 证	虚 证	实 证
症 状	神疲乏力，自汗，盗汗，心悸，耳鸣，语音低微，气短，面色不华，久泄，食物不化，腰酸遗精等	腹胀胸满，喘逆气粗，胁腹痞块，疼痛拒按，大便秘结或腹痛下痢，小便不通，少腹胀满等
脉象、舌苔	脉细小无力，舌质淡或红，少苔	脉弦实有力，舌苔厚腻

表 里

凡病在人体的浅表、肌肤、经络的，都属于表证的范围；病在脏腑的，

都属于里证的范围。治疗方法，表证用发汗、解表、疏通经络等方法，里证治法在“病邪辨证”与“脏腑气血辨证”中介绍。表证与里证见表 3-2。

表 3-2 表证和里证简表

辨 证	表 证	里 证
症 状	怕冷，发热，头痛，身痛，鼻塞，四肢关节酸痛等	发热，烦躁，口渴，胸闷呕吐，胁痛腹痛，便秘或泄泻等
脉象、舌苔	脉浮，苔薄白	脉滑数或沉弦，舌苔腻

寒 热

寒证多为人体机能衰退的证候；热证多为人体机能亢盛的证候。治疗

方法，热证用清热、凉血、泻火、解毒等方法，寒证用回阳、温中、散寒的方法。寒证和热证见表 3-3。

表 3-3 寒証和热証简表

辨 証	寒 証	热 証
症 状	面色苍白,恶寒,蜷卧,脘腹疼痛,得热痛减,大便清薄,小便清长,四肢不温等	身热不恶寒,面红,目赤,口干喜饮,大便秘结,烦躁,谵语,小便黄赤,吐痰黄稠,唇焦齿燥等
脉象、舌苔	脉沉细或迟或弦紧,舌苔白润	脉数有力,舌质红,苔黄腻干燥

阴 阳

阳证,即一般所称的热证,以及外科疮疡,局部红肿热痛,脓液稠厚发臭等,偏实的较多;阴证,即一般所称的寒证,以及外科疮疡,局部不红不热不痛,脓液稀薄等,偏虚的较多。治疗方法同寒证和热证。

阴阳在辨证上的另一含义,是指机体内脏功能活动和各种体液。一般以气称为阳,精、血、津液称为阴。如肾阳不足,肾阴亏损,脾阳不振,胃阴虚耗等等,都表示着内脏功能活动减退和体液虚亏的情况。

运用八纲辨证,结合病因,必须全面分析。如表证又有表虚、表实、表寒、表热之分;里证又有里寒、里热、里虚、里实之别;寒有虚寒和实寒;热有实热和虚热等等。进行过细辨证,才能得出恰当的诊断。八纲的具体运用,必须同病邪辨证与脏腑气血辨证以及热性病的辨证等密切结合起来。例如要确诊一个疾病的虚实时,实,必须分析是属于风、火、痰、瘀、湿、滞等哪一种病邪,它发生在哪一个脏腑;虚,要分析是属于气虚、血虚、阴虚、阳虚、脾虚、肾虚等哪一类虚证。这样才能使八纲辨证具体化,达到辨证施治的目的。

二、脏腑、气血的辨证施治

心 病

一、虚证

1. 心阳虚:

主要证候:心悸,气喘,口唇、舌质甚至指甲青紫,心胸闷痛。或舌淡苔白。脉细小或大而无力。

治疗方法:振奋心阳,温通血脉,用附子,肉桂(或桂枝),丹参,红花等。

2. 心阴虚:

主要证候:心悸,失眠,多梦,虚烦,盗汗。舌质红,脉细数或细弱。

治疗方法:养心安神,用生地,当

归,麦冬,远志,柏子仁,酸枣仁等。

二、实证

1. 心火炽盛:

主要证候:心烦失眠,咽干口燥,面红目赤,口舌糜烂,吐血尿血。舌尖红或起刺,脉数。

治疗方法:泻心火,用生地,竹叶,木通,山栀,黄连等。

2. 痰蒙心窍:见“病邪的辨证施治”痰证条(第30页)。

3. 热传心包:见“热性病的辨证施治”血分热证条(第31页)。

肝 病

一、实证

1. 肝气郁结:

主要证候: 胁痛, 胸闷, 暖气, 恶心呕吐, 胃脘胀痛, 或腹痛则泄泻, 泻后腹痛无明显减轻, 脉弦。

治疗方法: 疏肝理气, 用柴胡, 郁金, 白芍, 香附, 川楝子等。

2. 肝火:

主要证候: 眩晕头痛, 急躁易怒, 面红目赤, 口苦口干, 大便秘结, 胁痛, 呕吐苦水或黄水。舌质红, 舌苔黄, 脉弦数。

治疗方法: 清肝泻火, 用龙胆草, 黄芩, 夏枯草, 钩藤, 菊花等。

3. 肝风:

主要证候: 眩晕, 头痛, 四肢麻木, 甚则震颤, 舌强, 言语不清, 舌伸出时歪斜抖动, 或突然跌倒, 昏迷, 抽搐。脉弦。

治疗方法: 平肝熄风, 用白蒺藜, 钩藤, 珍珠母, 地龙, 蜈蚣, 天麻等。

4. 寒滞肝脉:

主要证候: 少腹疝痛, 睾丸坠胀, 或阴囊收缩。舌滑润, 苔白, 脉弦或沉弦。

治疗方法: 温经暖肝, 用吴茱萸, 茴香, 乌药, 肉桂, 青皮, 橘核等。

二、虚证

肝阴不足, 肝阳上亢:

主要证候: 头晕头痛, 面部烘热, 夜寐不宁, 耳鸣, 眼花或雀目。舌红少苔, 脉弦细数。

治疗方法: 养阴潜阳, 用生地, 白芍, 女贞子, 旱莲草, 枣仁, 珍珠母, 牡蛎等。

脾 病

一、实证 在“病邪的辨证施治”湿证中介绍(第29页)。

二、虚证

1. 中气不足:

主要证候: 食欲不振, 神疲乏力, 大便稀烂, 腹部有重坠感, 消瘦, 脱肛, 子宫下垂等证。舌苔薄白, 脉细。

治疗方法: 补中益气, 用黄芪, 党参, 升麻, 白朮, 茯苓, 甘草, 红枣等。

2. 脾阳不振:

主要证候: 面色苍白, 大便稀薄且有不消化食物, 泛吐清水, 腹部冷感, 喜热, 小便清, 胃口不好, 乏力, 或见大腹胀满, 面浮足肿等证。舌质淡, 苔白, 脉濡软或沉细兼迟。

治疗方法: 温振脾阳, 用干姜, 补骨脂, 肉果, 白朮, 芫荽等。

3. 脾不统血:

主要证候: 便血, 尿血, 皮下出血, 月经过多, 面色苍白, 神疲乏力等。

治疗方法: 补脾摄血, 用黄芪, 党参, 白朮, 甘草, 黄芩, 仙鹤草等。

胃 病

一、实证

1. 胃热:

主要证候: 食后易饥, 口渴多饮, 胸脘嘈杂, 或食入即呕吐, 或牙龈肿痛, 口臭, 便秘。舌苔黄, 脉数。

治疗方法: 清胃热, 用知母, 石膏, 竹叶, 芦根, 大黄等药。

2. 胃寒:

主要证候: 脘腹冷痛, 得热则减, 恶心呕吐, 呃逆。舌苔白, 脉弦。

治疗方法: 温胃散寒, 用吴茱萸, 川椒, 生姜, 木香, 丁香, 制半夏等。

二、虚证

1. 胃阳虚:

主要证候: 空腹胃痛剧, 泛吐清水, 喜热喜按, 得食痛减。舌苔白, 脉沉细。

治疗方法: 温阳暖胃, 用黄芪, 桂枝, 干姜(或高良姜), 吴茱萸, 木香, 萸澄茄等。

2. 胃阴虚:

主要证候: 口燥, 咽干, 胃脘疼痛, 大便秘结。舌红少苔, 脉细数。

治疗方法: 益胃养阴, 用沙参, 麦冬, 玉竹, 白芍, 甘草, 石斛等。

肺 病

一、实证

1. 肺部痰湿:

主要证候: 咳嗽, 咯痰粘稠, 气短, 胸闷。舌苔白腻, 脉濡缓。

治疗方法: 化痰湿, 用陈皮, 制半夏, 苍朮, 茯苓, 厚朴等。

2. 肺部痰寒:

主要证候: 咳嗽, 气喘, 喉中有痰鸣声, 痰白色, 或稀薄如泡沫样。舌苔白, 脉弦紧。

治疗方法: 温肺化痰, 用苏子, 杏仁, 白芥子, 制半夏, 干姜, 细辛, 麻黄, 桂枝等。

3. 肺部痰热:

主要证候: 咳嗽, 痰黄稠或脓样, 或血痰, 气逆或喘, 胸痞, 口渴喜饮。舌苔黄, 脉数。

治疗方法: 清肺化痰, 用桑白皮, 冬瓜子, 鱼腥草, 黄芩, 竹沥半夏, 芦根, 海蛤壳等。

二、虚证

1. 肺气虚:

主要证候: 气短, 动则气喘, 痰液

稀薄, 懒言声低, 形寒怕冷。舌质淡, 苔薄, 脉软无力。

治疗方法: 补益肺气, 用黄芪, 党参, 五味子, 山药, 百合等。

2. 肺阴虚:

主要证候: 咳呛少痰, 或痰中带血, 咽干口燥, 午后颧红, 低热, 失眠, 盗汗。舌质红, 脉细数。

治疗方法: 养阴清肺, 用沙参, 麦冬, 百合, 生地, 功劳叶, 鳖甲等。

肾 病

1. 肾阳不足:

主要证候: 面色淡白, 怕冷, 头晕, 耳鸣, 听力减退, 腰酸肢软, 小便清长或频数, 阳痿, 遗精, 妇女白带多而稀薄。舌质淡, 苔薄白, 脉沉细。

治疗方法: 益肾温阳, 用熟地, 鹿角, 附子, 肉桂, 狗脊, 续断, 菟丝子, 仙灵脾等。

2. 肾阴亏损:

主要证候: 头晕眼花, 腰酸耳鸣, 虚烦失眠, 健忘, 遗精早泄, 口干。舌红少苔, 脉细数。

治疗方法: 滋阴益肾, 用龟板, 熟地, 山萸肉, 枸杞子, 女贞子, 天冬, 潼蒺藜等。

3. 肾不纳气:

主要证候: 短气喘促, 动则更甚, 咳嗽, 易出汗, 怕冷, 面部虚浮。脉细无力, 或沉细。

治疗方法: 益肾纳气, 用熟地, 山萸肉, 胡桃肉, 五味子, 补骨脂, 紫石英等。

4. 肾虚水泛:

主要证候: 周身水肿, 下肢尤甚, 按之凹陷, 形寒肢冷, 咳嗽, 痰稀薄, 动则气喘。舌质淡, 苔白, 脉沉。

治疗方法：益肾温阳利水，用附子，桂枝，茯苓，白朮，泽泻，车前子等。

膀胱病

一、实热 见“病邪的辨证施治”中湿证“膀胱湿热”条(第29页)。

二、虚寒

主要证候：小便频数而清长，或小便不禁，遗尿。舌淡苔润，脉沉细。

治疗方法：固摄膀胱，兼补肾气，用桑螵蛸，覆盆子，益智仁，菟丝子，牡蛎，龙骨等。

肠病

一、热证

1. 肠腑燥结：见“热性病的辨证施治”气分热证(2)条(第31页)。

2. 湿热滞留：

主要证候：身热腹痛，痢下赤白，里急后重，肛门灼热。舌苔黄腻，脉数。

治疗方法：清热、燥湿、导滞，用白头翁，黄连，黄柏，秦皮，焦山楂，槟榔，木香等。

3. 瘀热阻滞：

主要证候：初起多见脐腹部疼痛，随即转移至右下腹部，疼而拒按，便秘或腹泻，发热。舌苔黄腻，脉数有力。

治疗方法：清热、化瘀、通滞，用蒲公英，厚朴，大黄，丹皮，桃仁，红藤等。

二、寒证

1. 受寒挟滞：

主要证候：肠鸣漉漉，脐腹胀痛，大便泄泻，小便清利。舌苔白腻，脉缓。

治疗方法：散寒化滞，用紫苏，藿香，厚朴，神曲，焦山楂，枳壳，木香等。

2. 肠虚滑脱：

主要证候：久痢、久泻不止，肛门下脱，四肢不温，神疲乏力。舌淡苔

薄，脉细无力。

治疗方法：瀉肠固脱，用诃子，赤石脂，干姜，肉豆蔻，五倍子等。

气 证

一、气虚

主要证候：神疲乏力，懒言，语音低微，自汗，眩晕，食欲不振。舌苔薄，脉软弱。

治疗方法：补气，用黄芪，党参，白朮，茯苓，甘草，红枣等。

二、气滞

主要证候：胸闷脘胀，嗳气稍舒，或胸胁脘腹攻走疼痛，妇女痛经、少腹墜胀等。脉多弦。

治疗方法：理气，用香附，木香，川楝子，枳壳，郁金，陈皮，乌药等。

血 证

一、血虚

主要证候：头晕眼花，心悸，虚烦失眠，手足发麻，面色苍白，口唇、指甲苍白。舌质淡，脉细。

治疗方法：补血，用当归，熟地，白芍，何首乌，旱莲草，桑椹子等。

二、血瘀

主要证候：疼痛，其部位固定不移，跌打损伤，各种出血而血色紫暗有块，腹内肿块，皮肤红斑或血肿。唇舌青紫，脉细涩。

治疗方法：活血化瘀，用当归尾，赤芍，生地，川芎，红花，桃仁，丹参等。

三、血热

主要证候：吐血，鼻出血，尿血，便血，月经过多等，血色鲜红，或皮肤斑疹色红。舌质红绛，脉数。

治疗方法：凉血，用生地，赤芍，丹皮，紫草，茜草根，大小蓟等。

三、病邪的辨证施治

风 证

一、外风

1. 风邪侵袭肌表,出现表证,见“八纲辨证施治”(第24页)和“热性病的辨证施治”表证条(第31页)。

2. 风邪侵入经络。常与湿邪、寒邪一起侵入,并可化热。

主要证候:主要是关节疼痛。偏风,疼痛游走不固定。偏寒,疼痛较剧,遇冷或夜间加重。偏湿,疼痛比较固定,肌肤麻木,活动不便。化热,关节疼痛,局部红、肿、热、痛,发热,口渴,脉数。

治疗方法:祛风通络,化湿散寒。偏风者以祛风为主,用羌活,防风,桑枝,当归,秦艽,络石藤等;偏寒者以散寒为主,用羌活,桂枝,草乌,川乌,延胡索等;偏湿者以化湿为主,用苍朮,米仁,稀莩草,白芷,五加皮,木瓜等。化热则应清热祛风利湿,用忍冬藤,防己,黄柏,羌活,桑枝,米仁等。

二、内风

1. 肝风详见肝病(第26页)。

2. 热极生风:

主要证候:高热,头痛,项强,神志昏迷,弄舌,手指蠕动,抽搐。舌苔黄质红,脉数。

治疗方法:清热凉血,熄风镇痉,用大青叶,紫草,金银花,地龙,钩藤,生地,全蝎,蜈蚣等。

3. 血虚风热:

主要证候:皮肤瘙痒、干燥、粗糙、脱屑。

治疗方法:养血祛风,用当归,

生地,鸡血藤,羌蔚子,蝉衣,荆芥等。

湿 证

1. 湿困脾胃:

主要证候:胸闷腹胀,恶心呕吐,口中淡腻(或甜腻),四肢无力,胃口不好,大便稀薄。舌苔白腻,脉濡。

治疗方法:化湿健脾,用藿香,佩兰,苍朮,厚朴,茯苓,半夏,扁豆等。

2. 脾胃湿热:

主要证候:胸闷腹胀,不思饮食,口苦口干,肢体倦怠,黄疸色泽鲜明如橘,腹泻或便秘,小便黄赤。舌苔黄腻,脉濡数。

治疗方法:清热化湿,用苍朮,半夏,黄芩,黄柏,茵陈,海金沙,金钱草等。

3. 肝胆湿热:

主要证候:胁痛,口苦,目赤,黄疸,小便热赤。舌苔黄腻,脉数。

治疗方法:泻肝火,利湿热,用龙胆草,柴胡,山梔,黄芩,木通,泽泻,车前子等。

4. 膀胱湿热:

主要证候:小便频数,量少,色赤,尿道灼热痛,排尿不畅,或自行滴出,下腹胀满。

治疗方法:清热利湿,用黄柏,海金沙,金钱草,萹蓄,木通,车前子,滑石等。

5. 水湿泛滥:

主要证候:面部及肢体浮肿,按之凹陷,小便少,神疲乏力,面色苍白。